

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 01

SYSTÈME NATIONALE DE SANTE



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

Chaque pays dispose d'un certain mode d'organisation afin de répondre, au mieux, à la demande de santé ;

Cette organisation coordonne l'activité des professionnels de santé avec celle des différents partenaires contribuant au financement du système de soins. Cet agencement complexe est **le système de santé** ;

Il faut rappeler que depuis **2011**, le **droit à la santé** est considéré un « **droit constitutionnel** », et ce dans plusieurs articles. Le droit à la vie (article 20), le droit à la sécurité et à la protection de la santé (article 21), le droit aux soins, à un environnement sain, à la couverture médicale...

Cette constitutionnalisation du droit à la santé a donc engagé la responsabilité de **l'Etat**, des **établissements publics** et des **collectivités territoriales** dans la protection de la santé de l'ensemble des citoyens.

Pour consolider notre système de santé, le Maroc a lancé un chantier de réforme profonde et durable, basée sur la mise à niveau et la réhabilitation de l'ensemble de ses aspects, dans l'objectif d'assurer des services de santé efficaces et de qualité. La loi-cadre 06.22, promulguée en décembre 2022, a apporté des mesures ambitieuses visant à renforcer le système national de santé pour devenir plus robuste et plus résilient, capable de soutenir les grands chantiers dans lesquels le Maroc s'est engagé.

La mise en œuvre de quatre piliers de réforme :

- 🏠 **L'adoption d'une nouvelle gouvernance** qui vise à renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle des acteurs de santé ;
- 🏠 **La valorisation des ressources humaines**, à travers l'instauration de la loi relative aux garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé ;
- 🏠 **La réhabilitation de l'offre de soins** afin de faciliter l'accès aux services de santé et d'en améliorer la qualité ;
- 🏠 **La digitalisation du système de santé** à travers la création d'un système d'information intégré permettant de collecter, de traiter et d'exploiter les données du système de santé.

I. Définition et clarification des concepts :

1. Concept de santé :

La santé est encore plus difficile à définir que la maladie. Les définitions ont évolué au fil du temps ;

i. Définition de la santé : OMS adopté en 1946 et en vigueur en 1948

« Un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité »

Selon Evans et Stoddart, 1991 :

- * Définition trop large et irréalisable
 - * L'aspect « bien-être » n'est pas mesurable. Ce n'est que l'aspect négatif de la santé qui est mesurable. Elle met sur le même pied d'égalité les aspects physiques, psychologiques et sociaux
- ### **ii. Définition de Monnier et al, santé publique, santé de la communauté, Villeurbanne,**
- « La santé est l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine (Biologiques, psychologique et sociales) ». Cet équilibre exige :**
- * La satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme (nutritionnels, sanitaires, affectifs, éducatifs et sociaux) ;
 - * Une adaptation sans cesse remise en question, de l'homme à un environnement en perpétuel mutation.
- ### **iii. OMS « Rapport sur la santé dans le monde, 2000 »**
- * La santé est un « capital humain »
 - * La santé : consommation maximalisée d'une durée de vie de bonne qualité
 - * La mesure se fait par le poids des 'manques de santé' (les maladies, les années de vie perdues prématurément).

2. Service de santé / service de soins de santé :

Deux significations :

- * Établissement ou institution de santé ou une partie de celui-ci : Organisation d'intérêt public (service hospitalier), section ou département (Service des urgences, service de réanimation)
- * Ensemble de prestations de santé : Service public qui est défini comme étant une activité d'intérêt général assuré par une institution d'Etat et soumise au régime juridique du droit administratif.

3. Système de santé :

i. Définition d'un système :

- * C'est un organisme composé d'une multitude d'éléments qui agissent les uns sur les autres concourant au même ensemble d'objectifs.
- * Un système reçoit des inputs (entrées) qui sont convertis en outputs (sorties) par des processus.

ii. Définitions du système de santé :

« Toutes les activités dont le but essentiel est de **promouvoir, restaurer ou entretenir** la santé » (OMS, 2000), par exemple :

- * Les prestations des services de santé officiels
- * Les actions des guérisseurs traditionnels
- * Les interventions favorables à la santé comme l'amélioration de la sécurité routière et de l'environnement

Les systèmes de santé sont le résultat des **politiques de santé**

iii. La nouvelle réforme du système de santé Marocain

03 Objectifs :

- * Faciliter l'accès des citoyens aux services de santé,
- * Améliorer la qualité de ces services,
- * Assurer une répartition égale et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national.

La mise en œuvre de cette réforme repose sur 04 piliers :

1. Adoption d'une bonne gouvernance ;
2. Valorisation des ressources humaines ;
3. Mise à niveau de l'offre sanitaire ;
4. Digitalisation de tout le système de santé.

Loi-cadre 34-09 au système de santé et à l'offre de soins :

Le système de santé est constitué de l'ensemble des institutions, des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur **la base des 05 principes suivants :**

1. La solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention la conservation et la restauration de la santé ;
2. L'égalité d'accès aux soins et services de santé ;
3. L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;
4. La complémentarité intersectorielle ;
5. L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé ;

La mise en œuvre de ces principes incombe principalement à **l'état**.

Modèle de système de soins au Maroc (selon la loi 34-09) :

Un Système **pyramidal, intégré, hiérarchisé** et fondé sur les **Soins de Santé Primaires (SSP)**

Loi-cadre 06-22 au système de santé et à l'offre de soins :

L'ensemble des **institutions**, des **organismes**, des **actions** et des **ressources** y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé aussi bien dans le secteur **public** que dans le secteur **privé**, aux niveaux **national** et **régional** et qui sont organisés pour la réalisation des objectifs

Le 08 système national de santé est basé sur les principes suivants :

1. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé ;
2. La continuité des prestations de santé ;
3. L'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources, des structures et des prestations de santé sur l'ensemble du territoire national ;
4. La bonne gouvernance ;
5. L'adoption de l'approche genre dans l'élaboration des politiques, des programmes et des stratégies de santé ;
6. La gestion basée sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ;
7. La mutualisation des moyens ;
8. La mobilisation de l'ensemble des citoyennes et citoyens, des institutions, des organismes relevant des secteurs public et privé ainsi que des associations de la société civile et leur implication dans l'exécution de la politique de l'Etat relative à la prévention des épidémies, des maladies et des autres risques sanitaires, et celle relative aux programmes visant l'amélioration de la situation sanitaire de la population et la disponibilité des soins de santé de base.

Les 10 objectifs de l'Etat dans le domaine de la sante selon la loi cadre 06-22

1. Faciliter l'accès de la population aux prestations de santé et améliorer la qualité de ces prestations ;
2. Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national ;
3. Asseoir la territorialisation de l'offre de soins dans le secteur public et améliorer sa gouvernance à travers la création de groupements sanitaires territoriaux ;
4. Garantir la souveraineté en matière de médicaments ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé ;
5. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé ;
6. Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé ;
7. Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé dans ce domaine ;

8. Valoriser et mettre à niveau les ressources humaines travaillant dans le domaine de la santé à travers la mise en place d'une fonction sanitaire qui prend en considération les spécificités des fonctions et des professions du secteur ;
9. Mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs public et privé ;
10. Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la santé

Acteurs d'un système de santé :

1. Les communautés, les familles, les individus dans leur environnement social
2. Les prestataires de soins (modernes, traditionnel, ONG...)
3. L'administration sanitaire
4. Les agences de financement, les agences de contrôle (gouvernement, ONG, privé, Organisations internationales)

v. Objectifs / fonctions d'un système de Santé (OMS, 2000) :

04 Objectifs

1. Amélioration de la santé (niveau et équité)
2. Réceptivité aux attentes de la population
3. Protection contre les risques financiers et sociaux
4. Amélioration de l'efficience

Les 06 fonctions d'un système de santé :

1. **Prestations de services :** c'est la fonction principale d'un système de santé. Les bons services de santé sont ceux qui fournissent des soins efficaces, sûrs et de qualité à ceux qui en ont besoin, quand et où ils en ont besoin, avec un minimum de perte de ressources.
2. **Production de ressources :** la performance d'un système de santé dépend de la connaissance, des compétences, de la motivation et de la distribution du personnel chargé d'organiser et de fournir des prestations
3. **Information :** La transparence, l'allocation des ressources, l'amélioration des programmes et les décisions en matière de gestion dépendent de la qualité de l'information sanitaire.
4. **Médicaments, vaccins et technologies :** Un système de santé performant doit assurer l'accès équitable et rationnel aux médicaments essentiels, vaccins et technologies de qualité, sûrs,

efficaces, avec un bon rapport coût-efficacité.

5. **Financement** : le financement de la santé a pour objet de dégager des fonds suffisants pour assurer que les personnes qui en ont besoin utilisent les services et sont protégés de l'appauvrissement lié au paiement des services de santé.
6. **Administration générale des systèmes de santé** : la notion de 'stewardship' ou la **gouvernance** des systèmes de santé, parfois définie plus étroitement sous le terme de gouvernance, désigne l'ensemble des fonctions assumées par les pouvoirs publics en vue d'atteindre les objectifs nationaux de santé.

Les 05 composantes d'un Système de Santé de soins :

Généralement les différents systèmes de santé dans le monde se composent essentiellement de **cinq (05)** composantes qui sont :

1. Développement des ressources sanitaires ;
2. Organisation des ressources ;
3. Les ressources financières ;
4. L'offre de soins ;
5. La gouvernance.

04 Valeurs du Système de Santé

1. **La couverture universelle** : La couverture (sanitaire) universelle consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin.
2. **L'accès équitable** aux services de santé pour tous ceux qui ont besoin des services de santé, quels que soient leurs moyens financiers, doivent pouvoir y accéder ;
3. **La qualité**, les services de santé doivent être d'une qualité suffisante pour améliorer la santé de ceux qui en bénéficient ;
4. **La protection financière**, le coût des soins ne doit pas exposer les usagers à des difficultés financières.

Les 04 moyens du système de santé :

1. **La restauration** de la santé correspond à la distribution de soins à l'individu malade.
2. **La prévention** se propose d'éviter ou de réduire le nombre et la gravité des maladies ou accidents
3. **La promotion** de la santé élargit le concept de prévention ; elle met à la disposition des populations les moyens d'augmenter leur capital santé.
4. **L'éducation** pour la santé a pour objectif de mettre à la portée de tous l'information nécessaire à des choix adaptés à la santé présente et future.

Les 07 Qualités d'un système de santé :

1. **Global** : C'est-à-dire permettre une prise en charge globale des usagers (soins curatifs mais aussi et surtout préventifs, rééducation, réadaptation et promotion de la santé),
2. **Efficace** : Cette efficacité est de deux ordres, technique (l'obligation des résultats) et économique
3. **Accessible** : l'accessibilité géographique (il doit être proche de la population) et économique (le coût ne doit pas lui faire obstacle).
4. **Acceptable** : Le système de santé doit avoir l'assentiment de la population. Ceci explique les difficultés parfois rencontrées lorsqu'on veut appliquer une politique copiée Sur d'autres pays
5. **Equitable** : Être répartis d'une manière homogène dans le territoire (notion de couverture sanitaire et d'accessibilité géographique).
6. **Planifiable et évaluable** : Le rôle de la planification est de déterminer les ressources disponibles pour satisfaire les besoins et choisir les solutions aptes à modifier la situation.
7. **Souple et modifiable** : Il doit pouvoir s'adapter à toute situation nouvelle imposée par le type de morbidité (SIDA), Le progrès technologique (IRM) et les conditions Socio-économiques.

Les 03 principes fondamentaux de ce système concourent essentiellement à :

1. Allonger l'espérance de vie en bonne santé du citoyen,
2. Améliorer la qualité de son existence, pour permettre son implication active dans le développement économique et social
3. Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays.

Le Système intégré des services de santé

Ce système est organisé de façon que tous ses éléments soient disposés, organisés et coordonnés en fonction d'un objectif commun qui est la prise en charge de la santé d'une population.

Dans le SSI il ne doit pas y avoir de :

'Trous' dans la couverture des problèmes de santé : Ce qui n'est pas fait au Centre de santé devrait être fait à l'hôpital et vice versa (Toutes les situations pathologiques tendent à être couvertes)

Ni de chevauchement des fonctions : Chaque élément du système a des fonctions spécifiques les mieux adaptées à ses caractéristiques (efficacité et efficience)

4. Santé publique

Définition de la Santé publique :

L'OMS, en 1952, affirme que la santé publique : C'est l'art et la science de prévenir les maladies, de prolonger la vie, d'améliorer la santé physique et mentale des individus par le moyen d'actions collectives (principalement les domaines d'hygiène du milieu et la lutte contre les maladies transmissibles).

La santé publique est une discipline autonome qui s'occupe de l'état sanitaire d'une collectivité, de la santé globale des populations sous tous ces aspects : curatif, préventif, éducatif et social.

Son champ d'action couvre tous les efforts sociaux, politiques, organisationnels qui sont destinés à améliorer la santé de groupes ou de populations entières.

Les 5 objectifs de la Santé Publique

1. Assainir le milieu ;
2. Lutter contre les maladies ;
3. Enseigner les règles d'hygiène personnelle ;
4. Organiser des services médicaux et infirmiers en vue d'un diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies ;
5. Mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé.

Les 6 approches en Santé Publique

1. Approche verticale par problème de santé :

Le problème de santé est défini et les services sont organisés pour l'utilisation des méthodes à mettre en action afin de résoudre ce problème.

2. Approche horizontale par méthodes ou services :

Organiser un service pour répondre aux divers problèmes de santé pour lesquels il est requis.

3. Approche pluridisciplinaire de la Santé Publique :

- * Santé environnementale, Santé professionnelle, Santé mentale.
- * Education à la santé, Organisation des soins de santé, Nutrition.
- * Sciences sociales telles que l'anthropologie, la sociologie, Ethique.
- * Surveillance épidémiologique, Economie, Information, Formation
- * Gestion, management, Démographie, etc. ...

4. Approche multisectorielle :

- * Logements insalubres et les conséquences sanitaires
- * Pollution de l'eau, de l'air et des aliments
- * Tabac, alcool, drogues
- * Conditions de travail et leurs conséquences
- * Urbanisme, bruits promiscuité et problèmes de stress

5. Approche genre :

- * Constitution marocaine de 2011 (...l'état œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes

et les femmes.)

- * Loi cadre n °34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins (...l'adoption de l'approche genre en matière de service de santé...)

6. Approche droit :

- * Constitution 2011

Les 08 fonctions de la santé publique (4 essentiels et 4 appuis)

1. Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires
2. Préparation et riposte de santé publique aux flambées de maladies, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence
3. Protection de la santé, y compris la gestion de la salubrité de l'environnement, de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité toxicologique et au travail
4. Promotion de la santé et prévention des maladies par des interventions en milieu communautaire, y compris par une action pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en matière de la santé
5. Garantir l'efficacité en matière de gouvernance de la santé, une législation de santé publique, un financement et un soutien institutionnel
6. Garantir un personnel suffisant et compétent pour des prestations efficaces en matière de santé publique
7. Communication et mobilisation sociale pour la santé
8. Faire avancer la recherche en santé publique pour avoir une influence sur les politiques et les pratiques

En santé publique : on évalue la pertinence de l'action, l'impact de l'action et la cohérence de l'action.

La santé communautaire :

Selon OMS, la santé communautaire est le processus par lequel les membres d'une collectivité, géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités.

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations.

La santé communautaire est l'approche locale des problèmes de santé d'une communauté impliquant sa participation active à toutes les étapes. Elle est mise en œuvre par un groupe associant professionnels et population. La priorité est la promotion de la santé. En cela, elle représente "l'horizontalisation" des priorités verticales fixées par la santé publique.

La santé communautaire nécessite la participation des membres de la communauté à la gestion de leur santé individuelle et collective.

Il y a une notion d'engagement de chaque individu.

La participation de la communauté est recherchée à tous les niveaux de l'action, c'est à dire :

- ✓ Analyser la situation sanitaire de la communauté,
- ✓ Identifier le problème, choisir les priorités,
- ✓ Définir les objectifs et activités, mobiliser les ressources pour améliorer la situation,
- ✓ Organiser et conduire l'action,
- ✓ Évaluer l'action.

La santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie au sein des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est d'être populationnelle et non individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. Elle est fondée sur plusieurs grands principes :

- ✓ **La santé est liée à un ensemble de facteurs** (démographiques, géographiques, sociaux, économiques...) qui ne touche pas qu'un individu mais toute une population, i.e. une communauté ; ces facteurs sont répartis de manière inégale entre les territoires ;
- ✓ **La médecine, le système de soins et les politiques publiques** n'apportent pas toujours une approche assez globale de la santé ;
- ✓ **Les comportements individuels sont difficiles à faire changer** ; l'implication des « gens » est fondamentale pour parvenir à un changement ; il ne s'agit pas de « faire pour » les gens, mais « avec » eux.

La prévention :

La prévention est l'ensemble des actions qui tendent à promouvoir la santé individuelle et collective. On distingue **4 types** de préventions mais selon **OMS**, il existe **3 types** :

- 1. Prévention primaire :** C'est l'ensemble des mesures destinées à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population. Ce sont les mesures visant à protéger les sujets susceptibles. Elle s'adresse aux sujets sains pour maintenir leur santé. **Ex** : vaccination
- 2. Prévention secondaire :** Il s'agit de l'ensemble des mesures destinées à diminuer la prévalence d'une maladie dans une population. Ce sont les mesures de dépistage précoce des cas infra cliniques, afin de les prendre en charge le plus tôt possible. Elle est basée principalement sur les mesures thérapeutiques. **Ex** : dépistage d'une maladie.
- 3. Prévention tertiaire :** Elle comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques et des récives, ce qui permet de réduire au maximum les invalidités fonctionnelles motrices. Réadaptation motrice, fonctionnelle, Réinsertion sociale, professionnelle. **Exemple** : rééducation après réparation d'une lésion traumatique due à un accident.
- 4. Prévention quaternaire :** action menée pour identifier un patient ou une population à risque de surmédicalisation, le protéger d'interventions médicales invasives, et lui proposer des procédures de soins éthiquement et médicalement acceptables (ex EBM)

Médecine préventive	Médecine préventive	Médecine curative	Réhabilitation
Prévention primaire	Prévention secondaire		P. tertiaire
La Prévention			

5. Offre de soins / Système de soins / Système de l'offre de soins.

Est composé des éléments suivants selon la Loi cadre 34-09 au système de santé et à l'offre de soins :

1. Les ressources humaines,
2. L'ensemble des infrastructures sanitaires des deux secteurs public ou privé et toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles.
3. Les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités.

Selon la loi-cadre 06-22 ; L'offre de soins comporte

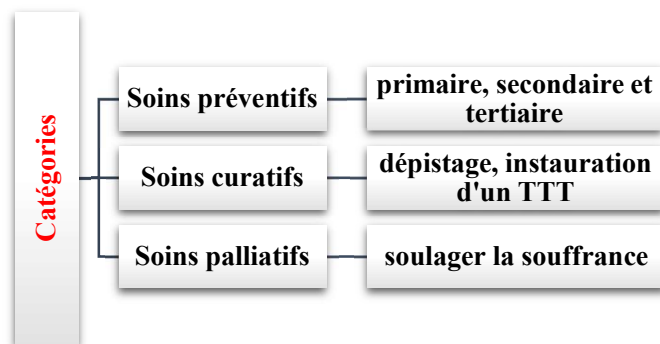
1. Les ressources humaines
2. Ensemble des infrastructures sanitaires relevant des secteurs **publics** et **privé**
3. Toutes autres installations de santé, **fixes** ou **mobiles**
4. Les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé.

Établissements de santé :

Les divers établissements, quel qu'en soit le régime juridique, organisés dans le but de contribuer à l'offre de soins.

Soin de santé :

- * **Acte** (ensemble de gestes) qui vise le bien être d'un individu ou d'un groupe d'individus.
- * **Les soins de santé** sont l'ensemble de connaissances, de compétences et de techniques relatives à la conception et à la mise en œuvre d'actes qui contribuent à répondre aux besoins de santé d'une personne et/ou d'une collectivité, et font l'objet de la discipline enseignée au personnel soignant. Ces soins font appel aux sciences humaines et biologiques.



6. Soins de santé primaires (OMS, Alma - Ata (U.R.S.S.) 1978) :

- * Soins de santé essentiels, (actions de promotion et prévention, des soins curatifs et de réadaptation)
- * Ils représentent le premier niveau de contact des individus, de la famille et de la communauté avec le SNS »
- * Universellement accessibles à tous les individus et toutes les familles de la communauté.
- * Par des moyens qui leur sont acceptables
- * Avec leur pleine participation
- * Et à un coût abordable pour la communauté et le pays.

La promotion de la santé

- * C'est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci et pour développer la capacité des individus et des communautés à participer activement à leur santé et à leur bien-être.
- * Le niveau d'action peut être local, régional et de nature participatif.
- * C'est un processus d'échanges, de concertation et de partenariat avec la population, les leaders, les représentants et les organisations.
- * Il Permet la diminution des facteurs de risque par apprentissage de modes de vie sain,
- * Il Permet aux communautés d'aménager leur environnement, etc....
- * La promotion de la santé représente un processus **social et politique global**, qui comprend non seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais également des mesures visant à changer la **situation sociale, environnementale et économique**, de façon à réduire ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des personnes.
- * La promotion de la santé est le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d'améliorer ainsi leur santé.
- * La participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santé.

7. Déterminants de la Santé :

- * Selon l'OMS, **les déterminants de la santé sont** les facteurs **personnels, sociaux, économiques et environnementaux** qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations
- * Selon l'OMS, **les déterminants sociaux** de la santé sont « les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie.

Selon **Evans & Stoddart**, 1991 il existe 4 catégories de déterminants de l'état de santé :

1. Facteurs endogènes (biologie, génétique)
2. Facteurs environnementaux
3. Facteurs mode de vie (comportements sociaux) ou les habitudes de vie
4. Facteurs liés au système de santé ou l'organisation du système de soins

Ce sont des facteurs multiples ayant une influence directe ou indirecte sur l'état de santé. Ils sont positifs (de protection) ou négatifs (de risque)

8. La carte sanitaire selon la loi cadre 34-09

- * La carte sanitaire a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publique et privée, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population, de réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines, de corriger les déséquilibres régionaux et intra régionaux et maîtriser la croissance de l'offre.
- * La carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du territoire national, en fonction du bassin de desserte de la population et de ses caractéristiques épidémiologiques, géographiques, socio-économiques et administratives

La carte sanitaire détermine au niveau national, interrégional et pour chaque région :

- * L'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante,
- * L'importance, la nature et le bassin de desserte des infrastructures et des installations fixes et mobiles publiques et privées à prévoir.
- * Les normes, les critères et les modalités d'implantation des infrastructures et des installations sanitaires.

La carte sanitaire est réalisée par l'administration centrale après avis de la commission nationale de l'offre de soins pour une durée maximum de 10 ans.

9. La carte sanitaire nationale selon la loi cadre 06-22 :

L'administration établit une carte sanitaire nationale qui détermine les orientations générales de la répartition de l'offre de soins sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante et des données géo-démographiques et épidémiologiques au niveau national.

Chaque groupement sanitaire territorial établit, dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale, une carte sanitaire régionale de l'offre de soins qui comporte un inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs public et privé et détermine, pour le secteur public, les mesures et les dispositions à même de garantir :

- * La satisfaction, de manière optimale, des besoins de la population en soins et prestations de santé au niveau régional et ce, en établissant les projections relatives notamment, aux ressources humaines, aux établissements de santé, aux lits et places, aux spécialités, aux installations fixes et mobiles, aux équipements lourds ainsi que leur répartition spatiale ;
- * L'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles au niveau régional ;
- * La réduction des disparités au sein de la région concernée en matière de l'offre de soins

10. Le schéma régional de l'offre de soins (SROS) selon la loi cadre 34-09 :

Le schéma régional de l'offre de soins est un outil de planification et de l'organisation de l'offre de soins au niveau régional, il détermine par préfecture ou province, eu égard à la carte sanitaire, en fonction du découpage sanitaire intra régional et sur la base de l'analyse des besoins.

- * L'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante.
- * La projection des établissements de santé, des lits et places, des spécialités, des installations fixes et mobiles publiques et privées et des équipements lourds ainsi que leur répartition territoriale.
- * La répartition territoriale et les projections des effectifs des ressources humaines.

Le SROS est établi par la direction régionale de la santé, pour une période de 5 ans.

11. La carte sanitaire régionale selon la loi cadre 06-22 :

Chaque carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changements survenus dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale.

II. Typologie des systèmes de Santé dans le monde :

Chaque pays a organisé son propre système de santé selon ses aspirations historiques, politiques et morales. Deux systèmes de prise en charge de soins servent de référence : le système Bismarkien (Allemagne) et système Béveridgien (Grande Bretagne).

1. Principaux modèles fondateurs :

Les 2 modèles fondateurs	
BERIDGE	BISMARCK
1942 : système de protection sociale fondé sur la socialisation des couts à l'échelle nationale. 3 principes : les 3U • Universalité : toute la population est prise en charge • Unique : système administratif central gère tout • Uniforme : même bénéfices pour tous Gestion par Etat Financé par l'impôt Angleterre, Suède, Norvège...	Fin du 19 -ème siècle Protection sociale sous réserve d'une activité salariée : système d'assurance sociale individuelle 4 principes : Réservé aux salariées Principe de l'assurance : les cotisations sont proportionnelles aux salaires et les prestations sont proportionnelles aux cotisations Gestion décentralisée par les salariées et les employeurs Allemagne, France, Pays-Bas...

2. Différents systèmes de santé dans le monde :

- * Les systèmes universels dits « Beveridge » (Angleterre, Espagne, suède, canada ...etc.).
- * Les systèmes professionnels dits « Bismarck » (Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Japon...etc.).
- * Système hyper libéral (USA, Liban).
- * Système communiste (Cuba).
- * Système socialiste en mutation (ex-bloc socialiste)

- * Système rentier, financé par une ressource naturelle (Quelques pays du Golf).

Historique et réformes du Système National de santé :

La naissance du système national de santé au Maroc : la première conférence nationale sur la santé organisée en Avril 1959 sous la présidence effective de feu S.M. Mohamed V, l'orientation générale de la politique sanitaire :

- * La santé de la nation incombe à l'État.
- * Le Ministère de la santé publique doit en assurer la conception et la réalisation.

Première période (1959-1981) : Mise en place et développement du système national de santé : (Infrastructures - Nationalisation des ressources - Lutte contre épidémies)

La première conférence nationale sur la santé organisée en Avril 1959 : La responsabilité de l'Etat sur la santé et le choix d'une politique de SP.

La Charte communale (1976) : responsabiliser les collectivités locales sur certains aspects de santé (hygiène et assainissement)

Déclaration d'alma Ata (1978) : c'est le fruit de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. Son objectif est la promotion des soins de santé primaires et l'accès de tous à un niveau de santé acceptable pour tous les peuples du monde.

Arrêté de 1980 : organiser la couverture sanitaire, renforcer les structures centrales et définir l'organisation et les attributions des services extérieurs.

Deuxième période (1981-1995) : Développement de l'offre et des programmes sanitaires : (Programmes - Renforcement du RSSB)

On assiste à un grand renforcement des structures sanitaires de base et au développement des programmes sanitaires. « 1^{ère} réforme »

Troisième période (1995-2000) : Quête de changement et annonce de la réforme : (Annonce de réformes - Stratégie sectorielle) « 2^{ème} réforme »

3^{ème} Réforme du système national de santé : La 2^{ème} Conférence Nationale sur la Santé (Marrakech, 1-3 Juillet 2013) a été l'occasion d'un débat national sur la santé dans le contexte de la nouvelle Constitution qui consacre le droit d'accès aux soins.

4^{ème} Réforme du Système National de Santé (SNS) au Maroc, inscrite dans le cadre de la généralisation de la protection sociale, repose sur quatre piliers principaux. Ces piliers sont : une bonne gouvernance, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre de soins, et la digitalisation du système de santé. La réforme vise à moderniser les infrastructures, améliorer la gouvernance et garantir un accès équitable aux soins pour tous les citoyens.

III. Les composantes du système de Santé au Maroc

Le système de Santé :

Chaque pays a son propre système de santé qui répond à sa politique sanitaire, à son niveau socio-économique et à ses priorités en matière santé.

- ✓ Le Système National de Santé Marocain se compose de **4 secteurs**
- ✓ L'offre de soins marocain se compose de **3 secteurs** : il ne contient pas le secteur traditionnel

S. Public

- Réseau hospitalier
- Réseau de soins de santé primaires
- RISUM, REMS
- Instituts et Laboratoires nationaux
- Services de santé des Forces Armées Royales
- Bureaux municipaux et communaux d'hygiène

S. privé à but non lucratif

- Les hôpitaux des établissements de soins de la CNSS, des mutuelles, de l'OCP et de l'ONE;
- Les cabinets dentaires et les laboratoires d'analyse des mutuelles;
- Les hôpitaux et les centres de soins du croissant rouge marocain;
- Les hôpitaux et centres de soins des ligues et des fondations

Composants du SNS

S. privé à but lucratif

- Les cabinets médicaux,
- Les hôpitaux et cliniques privés
- Les cabinets de médecine dentaire
- Les officines de pharmacie,
- Les opticiens et prothésistes
- Laboratoires d'analyse privés

S. traditionnelle

- C'est un secteur de médecine traditionnelle non formel auquel a recours un nombre relativement important de la population particulièrement en milieu rural.
- L'accouchement à domicile par les **Kablas** se pratique dans plusieurs cas, de même que les herboristes (qui assurent les soins par les plantes) et apporte une large contribution dans les traitements traditionnels

1. Le secteur formel qui comprend :

A. Le sous-secteur public (Etatique) :

a. Le Ministère de la Santé :

Le Ministère de la santé dispose d'un système national de soins de santé à travers l'ensemble du territoire organisé en réseaux : Réseau des hôpitaux, Réseau des soins de santé primaires, Réseau intégré des soins d'urgence médicale et Réseau des établissements médico-sociaux.

b. Les services de santé des Forces Armées Royales (FAR)

Ces services sont dotés d'une infrastructure sanitaire importante constituée d'hôpitaux et de camps avancés, d'infirmes de garnison et de sous-secteurs, de bataillons médicaux, de magasins d'approvisionnement sanitaire, d'écoles de santé militaire.

Les moyens d'intervention mis en œuvre à travers le pays sont destinés à assurer la prise en charge de la santé d'une population cible plus importante (des militaires et de leurs familles).

c. Les services de santé relevant des collectivités locales (BMH et BCH)

d. Instituts et Laboratoires nationaux (institut national d'hygiène, institut pasteur du Maroc...)

B. Le sous-secteur privé à but non lucratif qui compte :

(Le secteur mutualiste, des assurances et des établissements publics et semi-publics).

a. Les établissements de santé relevant des mutuelles¹

La Caisse Nationale des Œuvres de Prévoyance Sociale (C.N.O.P.S) : Contribue au financement des prestations sanitaires fournies par les établissements sanitaires publics ou privés, aux adhérents et leurs ayants droit. En plus, il fournit des soins à ses adhérents dans certaines structures sanitaires qu'il possède.

b. Les polycliniques relevant de la Caisse National de Sécurité Sociale (C.N.S.S) :

Cette institution d'assurance couvrant une gamme de prestations sociales et sanitaires à ses adhérents, salariés du secteur privé (allocations familiales, indemnités de retraite, indemnités journalières de maladie, indemnités journalières de maternité).

L'assurance médicale finançait des soins médicaux dispensés par le secteur privé et public.

La C.N.S.S est un établissement public doté de la personnalité civile. Elle est administrée par un conseil d'administration tripartite (24 membres) composé à part égale des représentants de l'Etat, des représentants des travailleurs et des employeurs.

c. Les services de santé relevant des établissements publics.

Certains de ces établissements se chargent eux même de la couverture et de la demande sanitaires de leurs employés et leurs familles.

Ils interviennent à cet effet au moyen des infirmeries, des hôpitaux et cliniques privées de la médecine de travail. Ex : O.N.E.P, O.C.P

d. Le Croissant Rouge, ligues et fondations

C. Le sous-secteur privé à but lucratif qui compte :

Les cabinets médicaux, dentaires et les cliniques privées fournissent leurs prestations sanitaires aux personnes couvertes par des assurances ou ayant des ressources financières leur permettant de régler leurs factures.

L'expansion rapide de la médecine privée, ces dernières années, vues comme le moyen d'alléger les pressions qui s'exercent sur les services publics surchargés.

- * Les Hôpitaux et cliniques privées
- * Les Cabinets libéraux
- * Les Opticiens prothésistes
- * Les Officines (Pharmacies)
- * Les infirmeries

2. Le secteur informel :

Le secteur traditionnel qui comprend :

- * Les Kablas (Accoucheuses traditionnelles)
- * Les herboristes, Les guérisseurs,
- * Les charlatans

La médecine traditionnelle occupe encore une place non négligeable dans notre pays et plus particulièrement au niveau des couches sociales démunies.

Les coutumes, les traditions et parfois l'inaccessibilité (Géographique, financière, culturelle) des services de soins modernes sont autant de facteurs qui poussent les gens à se donner à la médecine traditionnelle.

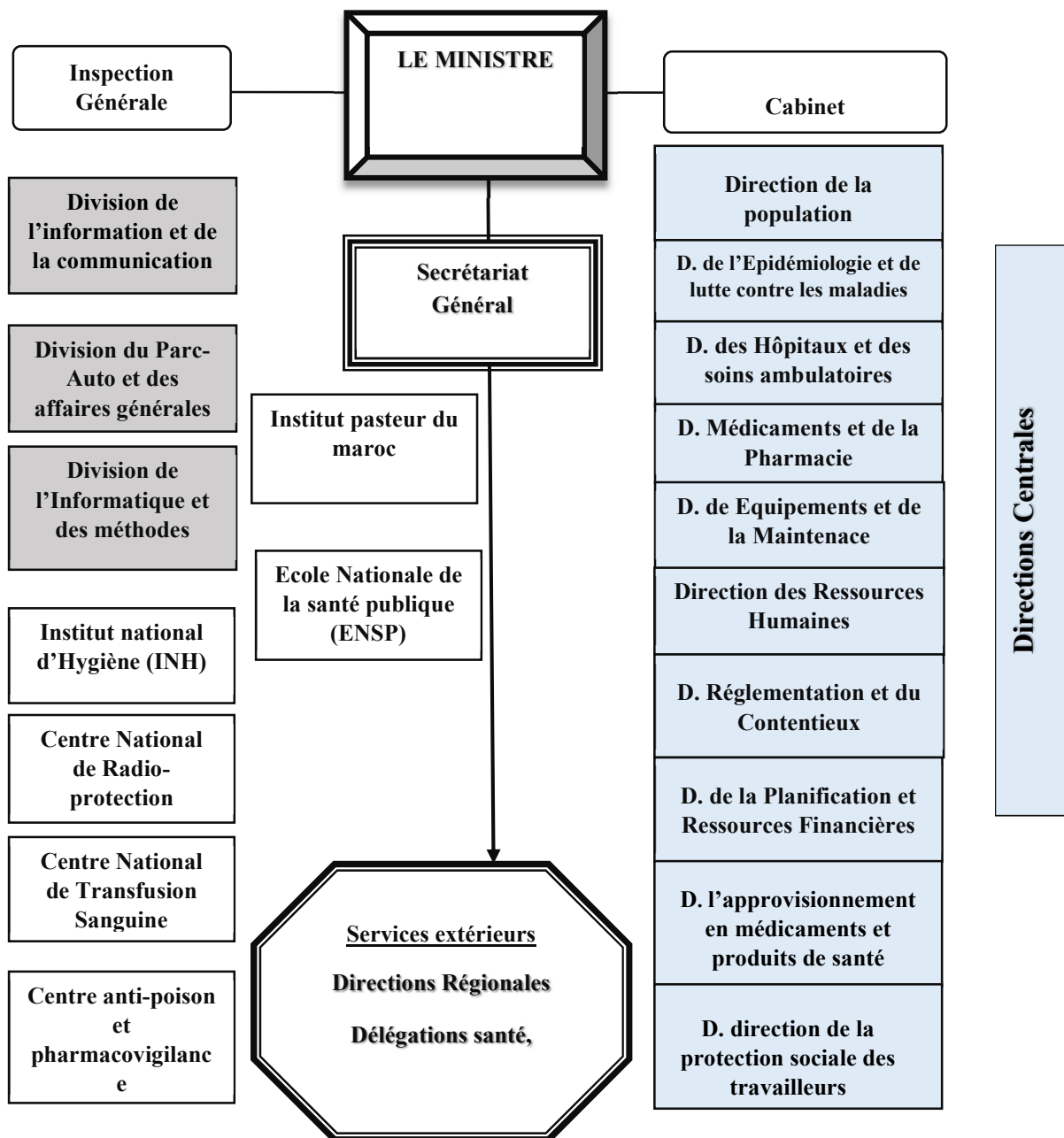
Ainsi par l'accouchement à domicile qui représente à peu près 13,4% des accouchements totaux, il s'avère nécessaire de s'occuper de ce secteur par la formation continue des « Kablas ».

IV. Organisation du Ministère de la Santé :

Le Ministère de la santé est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de la santé de la population. Il agit en liaison avec les départements concernés en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et sociale des habitants. Il harmonise les orientations et coordonne les objectifs et les actions ou mesures qui concourent à l'élévation du niveau de santé national à une meilleure allocation des ressources en matière de prévention, des soins curatifs ou d'assistance. Il suit la politique sanitaire internationale à laquelle

le Maroc adhère, définit en concertation avec les départements concernés les options de coordination dans le domaine de la santé. Il assure conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur le contrôle de l'exercice de la profession médicale, paramédicale et pharmaceutique

1. Organigramme du ministère de la santé et de la protection sociale



L'organisation du Ministère de la santé comprend à l'instar de la structure des autres départements un cabinet du ministre, une administration centrale et des services périphériques.

Les services concentrés sont représentés par les services de l'administration centrale du Ministère de la santé, alors que les services déconcentrés sont représentés par les services périphériques ou services extérieurs (les délégations provinciales, les directions régionales)

2. L'organisation de l'administration centrale

i. Missions de l'administration centrale :

- * Définition des priorités sanitaires nationales et élaboration de la politique gouvernementale en matière de la santé de la population
- * Planification de l'offre de soins (curatifs, de prévention et de promotion)
- * Régulation du financement, allocation des ressources aux régions et coordination du développement du secteur
- * Contrôle de l'exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques
- * Monitoring de la performance des institutions et processus de leur accréditation
- * Le ministre assure la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés (CHU, IPM,)
- * Développement de la législation sanitaire
- * Elaboration d'une politique sur la recherche et le développement.

ii. L'administration centrale comprend :

- * Le secrétariat général
- * L'inspection générale
- * **La direction de la population**
- * **La direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies**
- * **La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires**
- * **La direction des médicaments et de la pharmacie**
- * **La direction des équipements et de maintenance**
- * **La direction de réglementation et de contentieux**
- * **La direction des ressources humaines**
- * **La direction de la planification et des ressources financières**
- * **La direction de l'approvisionnement en médicaments et produits de sante**
- * **La direction de la protection sociale des travailleurs**

- * **La division du parc- auto et des affaires générales**
- * **La division de l'informatique et des méthodes**
- * **La division de la communication et l'informatique**

Par ailleurs sont assimilés à des services centraux, l'Institut National d'Hygiène, le centre national de radioprotection, le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie, institut pasteur du Maroc et l'école nationale de santé publique.

iii. Les attributions de l'administration centrale

L'administration centrale est conçue sur le modèle hiérarchique combiné avec le principe de spécialisation et de la division de travail et comprend :

- **Le Ministre de la santé :**

Il est nommé par le Roi sur proposition du chef de gouvernement. Il est responsable devant eux de la gestion des affaires relevant de son département. Ses fonctions sont complexes et sa compétence touche toutes les affaires de santé.

- * **En matière d'administration :** il assure l'entière direction de tous les services.
- * **En matière financière :** il prépare et présente le budget de la santé et le répartit entre les délégations préfectorales et provinciales et se charge de les contrôler.
- * **En matière technique :** il donne à la santé publique l'orientation et la politique fixée par le gouvernement :
 - Création de nouveaux services
 - Prise de toutes les décisions qu'il estime susceptibles d'une grande efficacité

- **Le cabinet du ministre :**

Est l'organe de décision le plus rapproché du ministre, avec lequel il prend forme et disparaît. Il est composé de personnes jouissant d'entière confiance du ministre. Il collabore avec lui d'une manière étroite et il se compose de :

- Un directeur de cabinet
- Un chef de cabinet chargé des affaires touchant de près le ministre
- Un ou plusieurs attachés de missions

Attributions :

- * Gestion des dossiers de santé de nature politique et qui ne relèvent pas des attributions des services centraux du MS
- * Mener des études
- * Aucune attribution dans la gestion des affaires techniques et administratives du MS
- * Pas d'autorité sur le personnel administratif et technique du MS

• Le Secrétariat général :

Institution rattachée directement au Ministre et dirigée par un secrétaire général, nommé par Dahir

C'est une institution qui assure sous l'autorité du Ministre des tâches techniques et administratives importantes et diverses,

A sa tête un secrétaire général, considéré comme deuxième responsable après le Ministre,

Il assure la continuité de l'administration sanitaire ainsi que la coordination des structures du département.

Attributions du SG :

- * Assiste le ministre dans l'orientation générale de la conduite des affaires concernant le département
- * Supplée le Ministre dans les rapports avec les administrations publiques et les autres partenaires du département
- * Peut représenter le Ministre dans toutes les réunions se rapportant aux activités du Ministère
- * Assure le contrôle, la coordination et l'animation des activités des directions, divisions et services, à l'exception de l'Inspection Générale (rattaché directement au Ministre)

• L'inspection générale :

- * Informe régulièrement le ministre sur le fonctionnement du service
- * Procède, sous l'autorité du ministre et sur ses instructions, au contrôle de l'utilisation des moyens et ressources mis à la disposition de tout le département
- * Assure, sous l'autorité du ministre, l'inspection administrative et médicale dans les formations et établissements de santé et procède à sa demande, à toute enquête et étude

- **Les Directions centrales :**

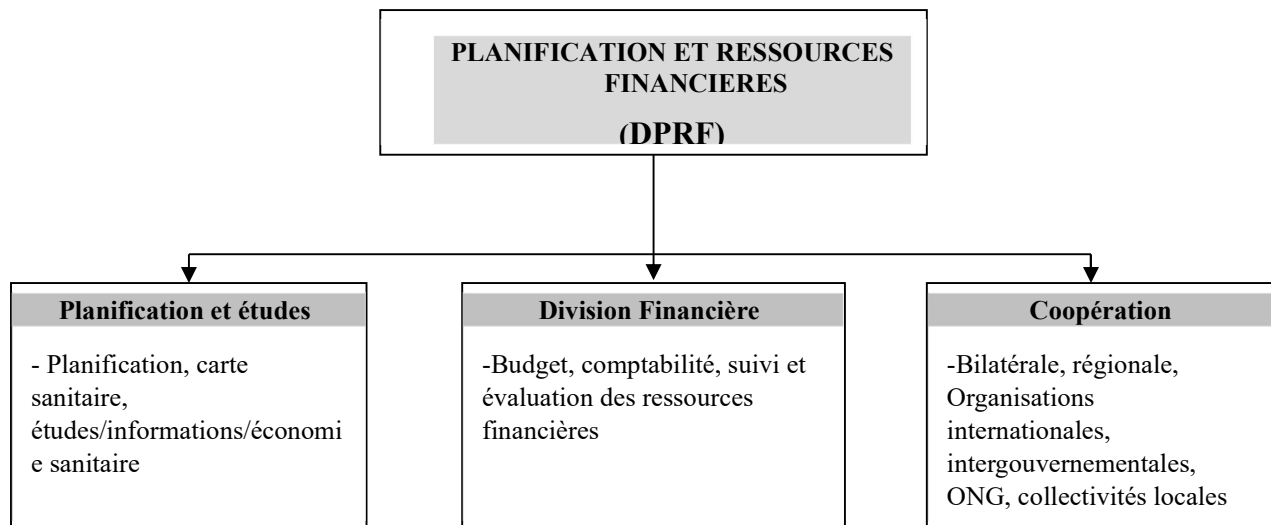
- * Constituent le centre de conception de l'action sanitaire, de direction et d'impulsion des structures qui leur sont rattachées (divisions et services) Les directions assurent les grandes tâches du département.

Attributions des services centraux

- * Formulation des politiques de santé applicables aux activités inter et intra sectorielles et fixation des priorités.
- * Elaboration des plans nationaux sanitaires
- * Allocation des ressources
- * Surveillance et évaluation de l'efficacité et efficience du système
- * Appui technique aux régions
- * Contrôle de qualité des produits pharmaceutiques
- * Réglementation du développement du personnel y compris la formation
- * Réglementation des organismes prestataires de soins secteur privé
- * Encadrement/coordination des établissements de soins nationaux et instituts d'enseignement et de recherche.
- * Développement de la coopération bi et multilatérale
- * Coordination des diverses sources de financement
- * Répartition rationnelle et équitable des fonds et subventions entre régions/provinces

i. Organigrammes et attributions des différentes directions

Direction de la planification et des ressources financières

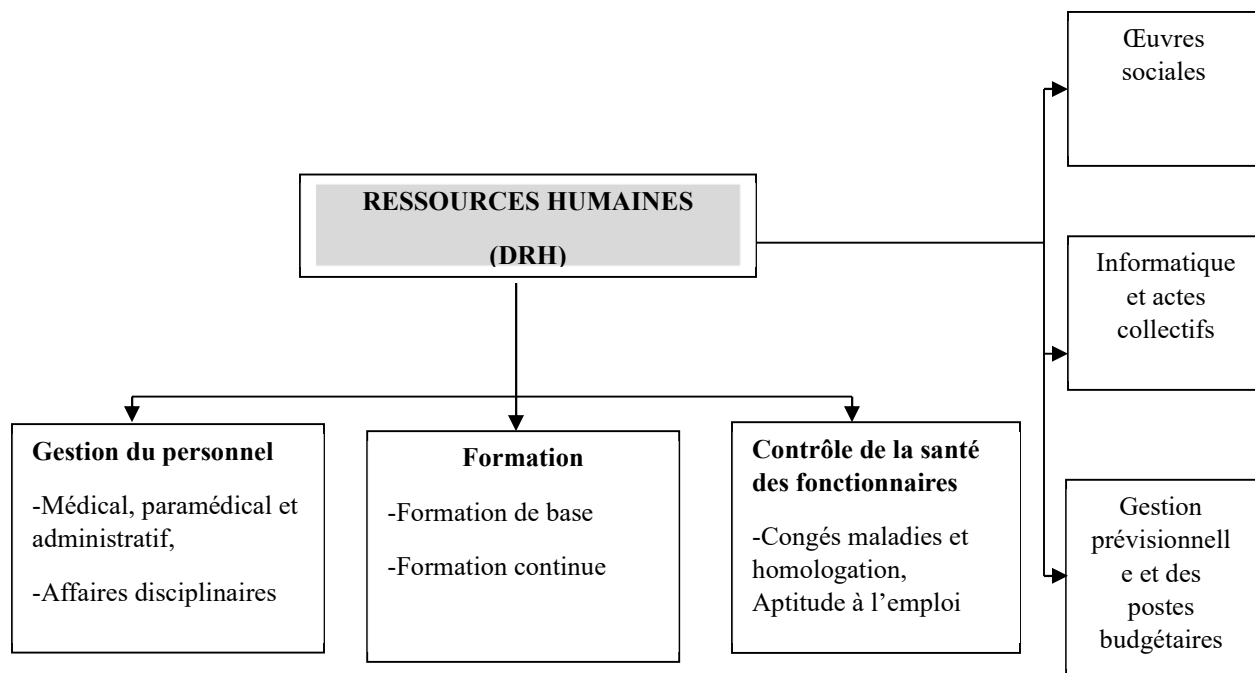


❖ Attributions :

- * Contribution à la définition des orientations en matière de la planification sanitaire dans le pays
- * Réalisation des études sectorielles ou intersectorielles en vue d'analyser la situation sanitaire.
- * Harmonisation des programmes d'action en liaison avec les organismes publics ou privés des méthodes comptables, conformément aux orientations nationales en matière de prévention, de soins et d'encadrement sanitaire.
- * Recherche et proposition des projets d'infrastructure liés à la carte sanitaire.
- * Coordination de l'action du ministère dans le domaine budgétaire et mise en place des crédits en les déléguant aux sous ordonnateurs et tenue de la comptabilité de tout le département.
- * Réalisation d'études économiques sur le système de santé en termes d'évaluation et de prévision.
- * Jouer le rôle d'observatoire d'utilisation des moyens budgétaires et extrabudgétaires
- * Contribution à la mise en œuvre du système de l'assurance maladie dans les limites des compétences du ministère.
- * Promotion de la coopération dans le domaine de la santé, recherche, inventaire et mobilisation des aides de coopération pouvant être consenties au Maroc pour le développement de la santé.

- * Promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale.
- * Identifier et coordonner avec les directions concernées et les partenaires intéressés les projets de coopération sanitaire ;

Direction des Ressources Humaines

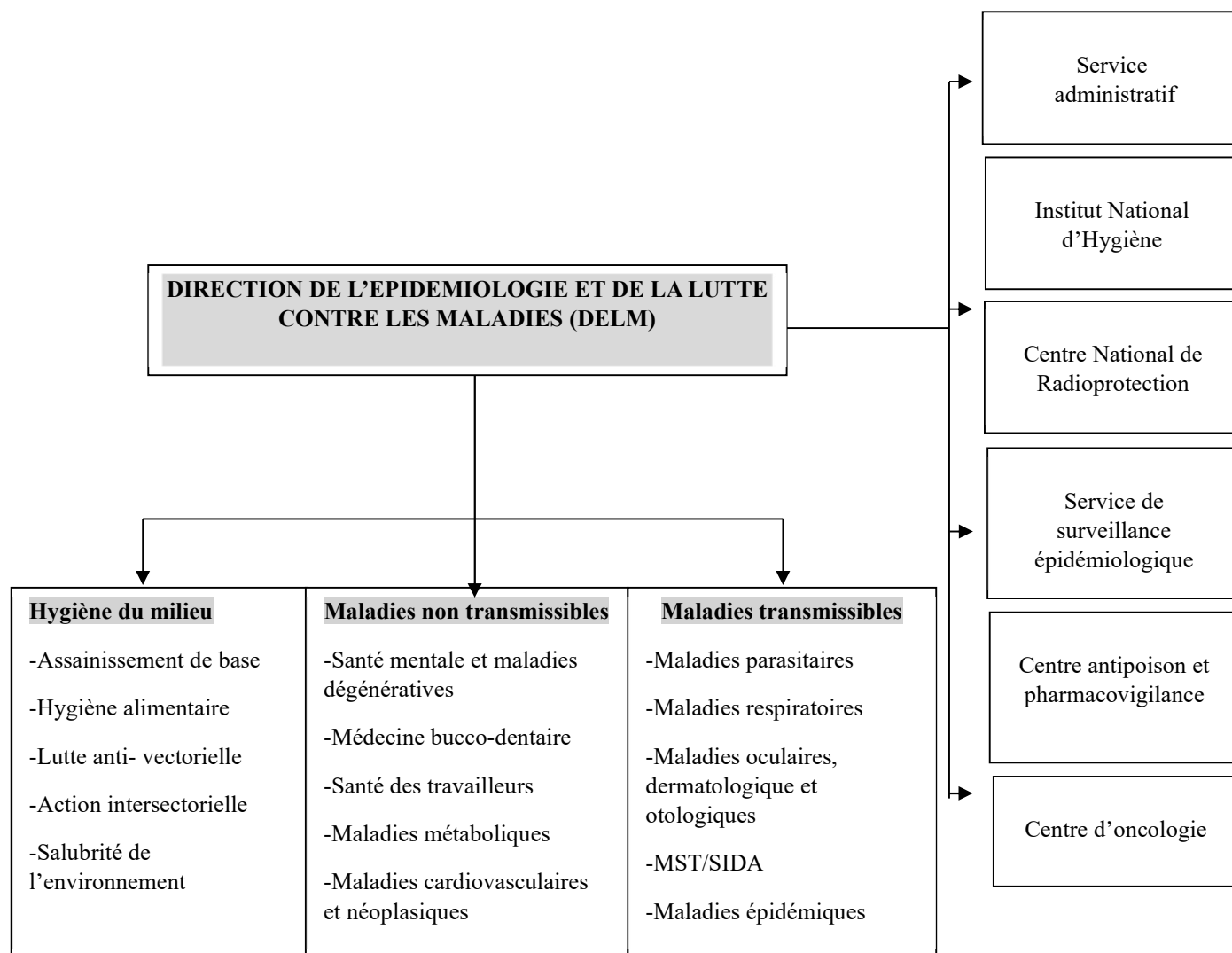


❖ Attributions :

- * Formation professionnelle et recyclage du personnel.
- * Affectation, recrutements, administration et gestion des affaires du personnel et promotion des actions d'œuvres sociales.
- * Réponse aux besoins exprimés par les différents services du département sur la base de plans d'acquisition et de développement des ressources humaines.
- * Elaboration et suivi des plans de formation des cadres administratifs, médicaux, pharmaceutiques, dentaires et des infirmiers en concertation avec le personnel concerné.
- * Evaluation de l'adéquation de la formation du personnel aux exigences du métier et emploi et adaptation des programmes de formation.
- * Tenue d'un fichier informatique du personnel.
- * Description des postes à des fins d'évaluation, de planification et de formation.

- * Etablissement des besoins qualitatifs et quantitatifs du ministère en personnel sur la base des priorités et des objectifs des plans.
- * Instruction des dossiers soumis au conseil de santé en matière de congés, maladies,
- * Homologations et contrôle de l'aptitude à l'emploi.

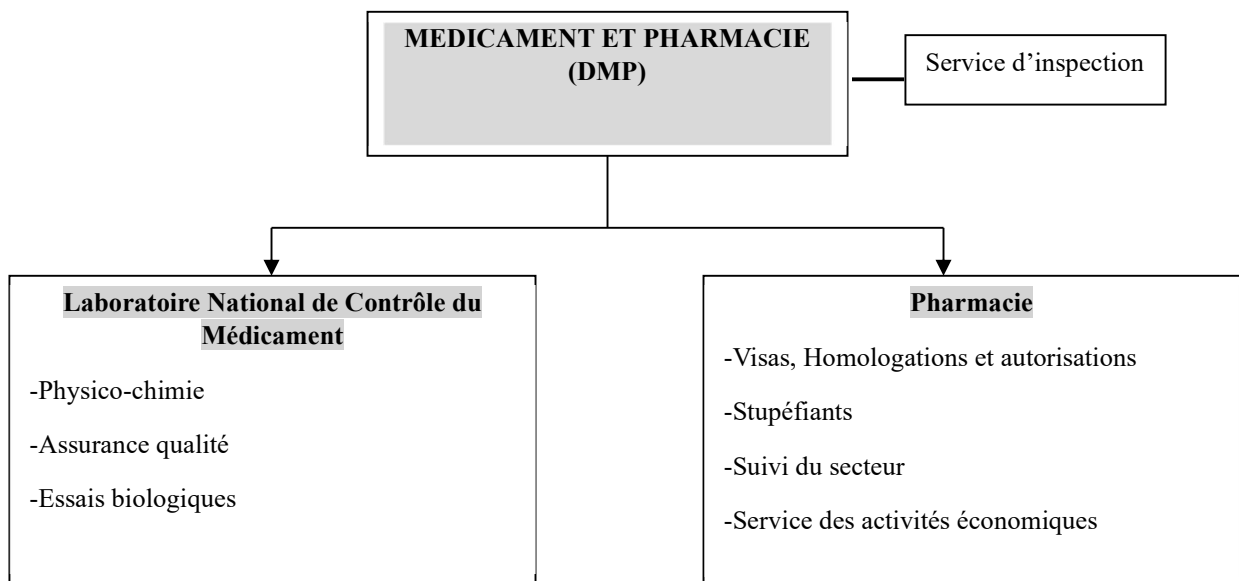
Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies



Attributions :

- * Surveillance épidémiologique de la population et tenue du fichier épidémiologique central.
- * Evaluation des caractéristiques épidémiologiques de la population et réalisation des enquêtes et études en matière d'épidémiologie.
- * Conception et réalisation des programmes de lutte contre les maladies
- * Programmation et réalisation des actions visant à protéger le milieu ambiant.
- * Contrôle de la qualité des laboratoires de biologie relevant du ministère et définition des normes techniques de leur fonctionnement.
- * Promotion et participation au contrôle de l'application de la réglementation en matière de radioprotection.
- * Contrôle sanitaire des denrées alimentaires.

Direction du Médicament et de la Pharmacie

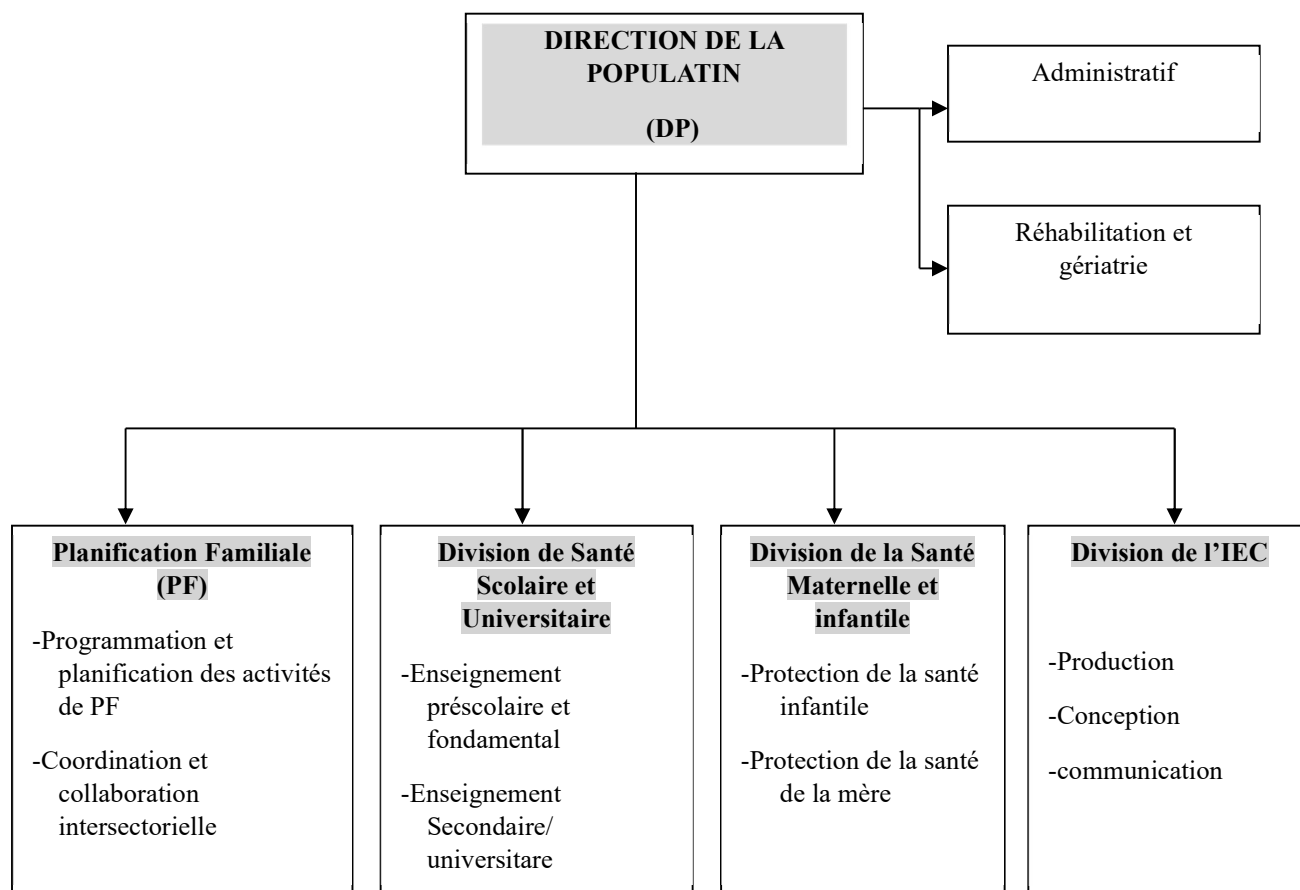


Attributions :

- * Elaboration des normes de fabrication, de conditionnement, de circulation, de vente et de stockage des médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
- * Fixation du cadre des prix des médicaments et des spécialités pharmaceutiques.
- * Contrôle technique et contrôle de la qualité des médicaments et des spécialités pharmaceutiques.
- * Etablissement et mise à jour de la liste des médicaments essentiels.

- * Détermination analytique et des essais nécessités par le contrôle des médicaments, des spécialités pharmaceutiques et des articles destinés à l'usage de la médecine.
- * Inspection des officines, grosseries et laboratoires de fabrication.
- * Délivrance des visas et des autorisations de débit des produits pharmaceutiques.
- * Gestion de la banque de données technique et économique sur les médicaments

La direction de la population

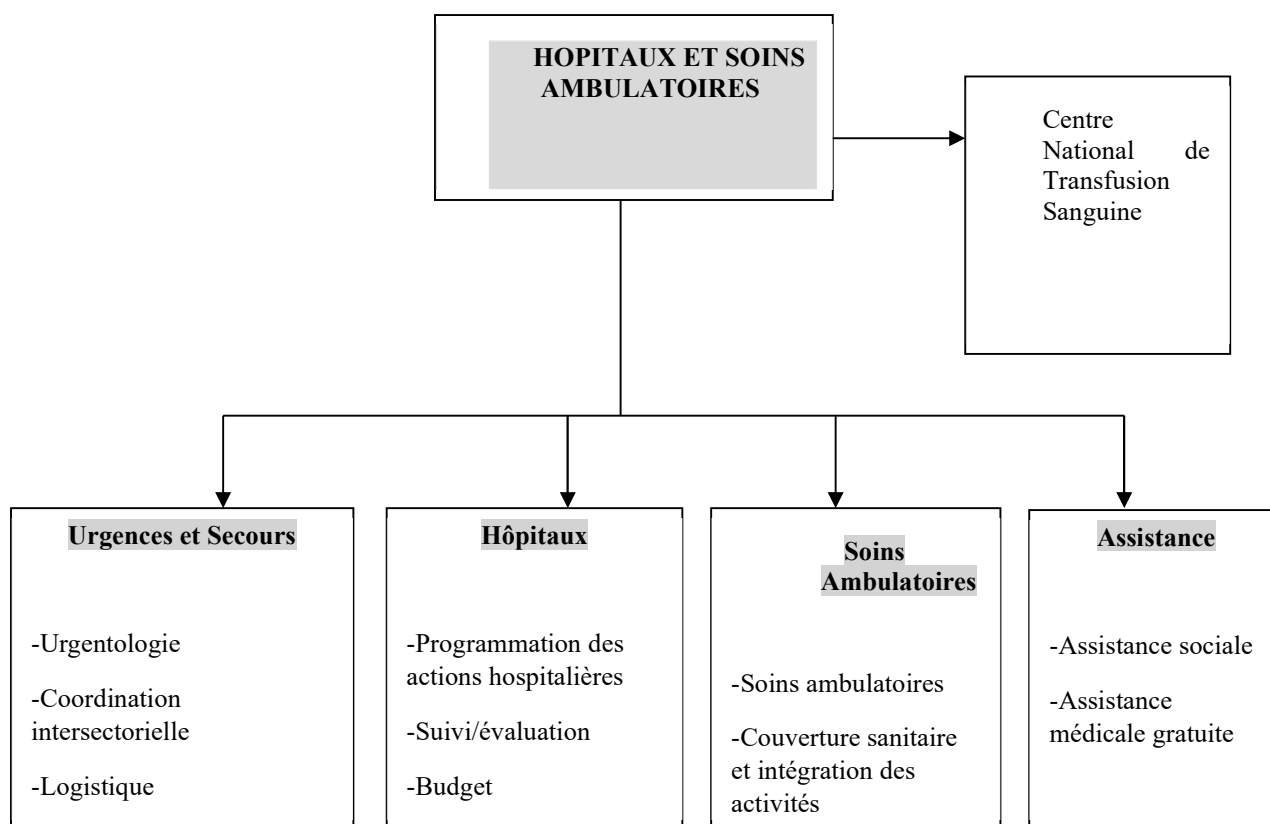


Attributions :

- * Promotion et exécution des programmes de planification familiale et des programmes relatifs à la santé maternelle et infantile.
- * Programmation et réalisation des actions de réhabilitation physique et de gériatrie.

- * Coordination des activités d'information, d'éducation et de communication des différents programmes.
- * Appui aux différentes directions et exécution des travaux pour le compte des différents programmes sur le plan d'Information / Education / Communication.

La Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires

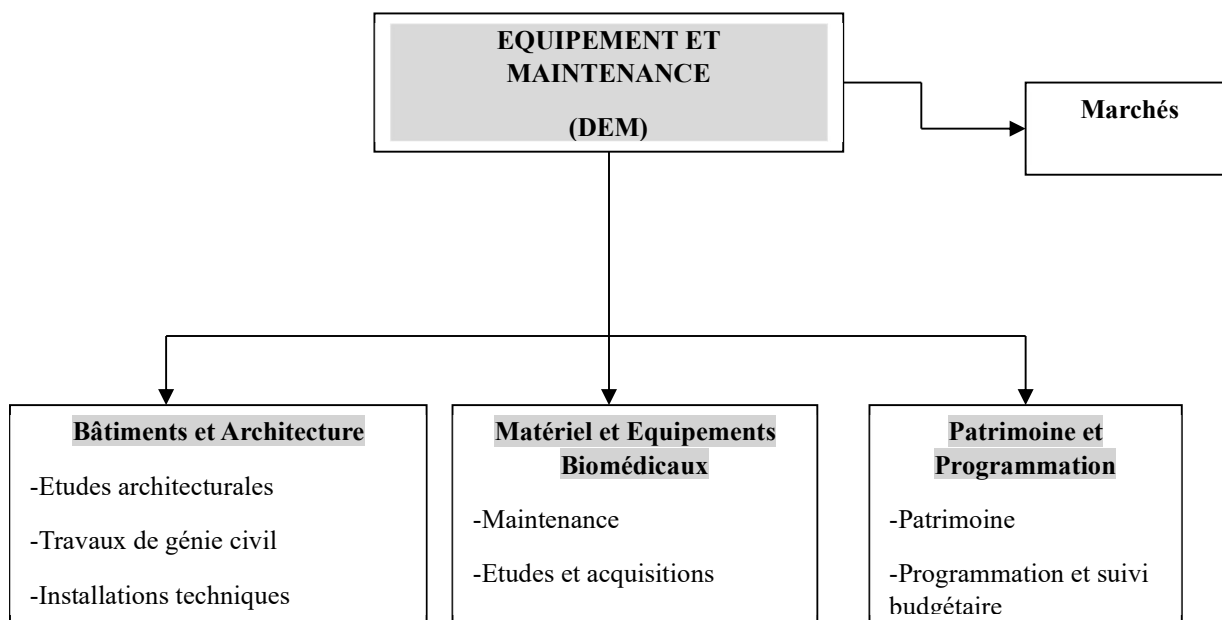


Attributions :

- * Coordination des actions du département en matière hospitalière et suivi des activités des hôpitaux.
- * Etablissement des bilans des activités des hôpitaux.
- * Contribution à l'élaboration de la stratégie du département en matière de soins ambulatoires.
- * Evaluation de l'action du réseau ambulatoire sur le plan de la qualité et de l'accessibilité des prestations.

- * Gestion de l'action du département en matière d'assistance sociale et de l'assistance médicale gratuite au profit des indigents.
- * Contribution au développement des moyens logistiques pour faire face aux catastrophes, y compris le ramassage médicalisé des victimes et la coordination des programmes.
- * Définition des stratégies de restructuration des services des urgences à travers le royaume.
- * Définition des programmes de formation en urgentologie et contribution à leur réalisation.
- * Organisation, planification et évaluation des tâches relatives à la collecte, au stockage, au traitement, à l'utilisation et à la distribution du sang et de ses dérivés.

La Direction des Equipements et de la Maintenance

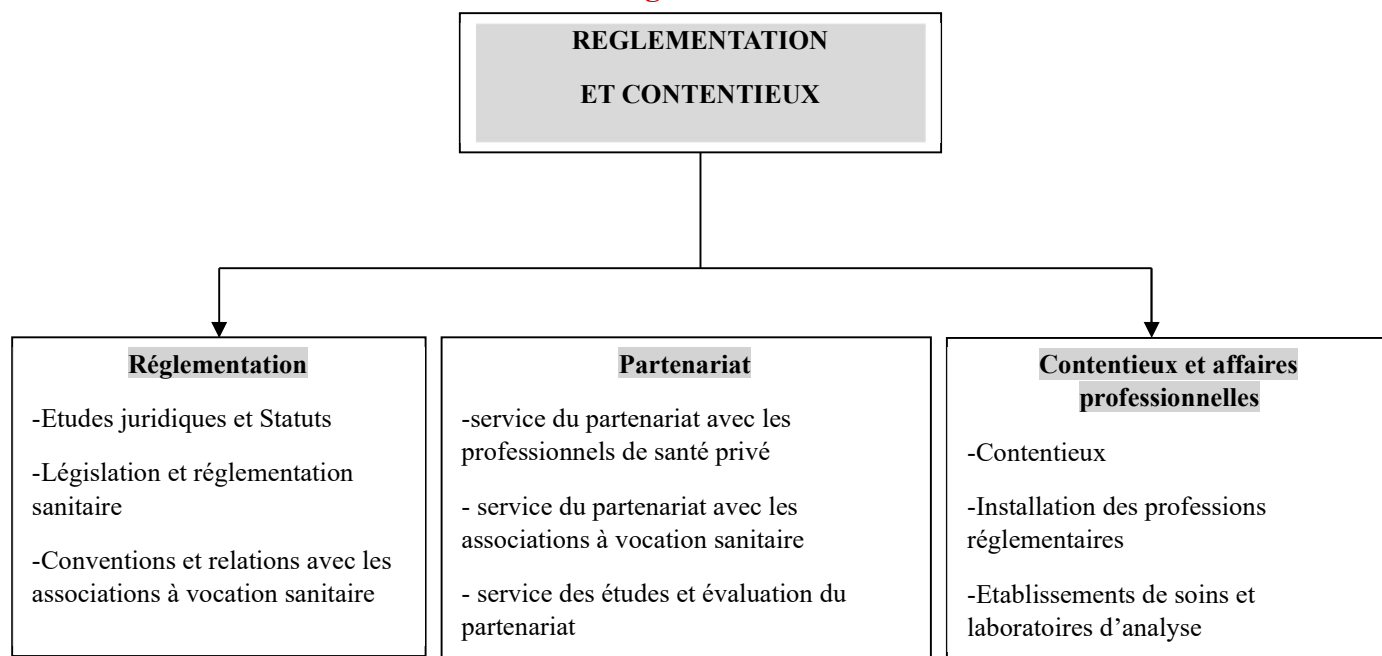


Attributions :

- * Exécution du budget d'investissement du ministère.
- * Etude et suivi de réalisation des projets d'architecture, de bâtiment et de construction.
- * Etude, programmation et suivi de réalisation des projets d'équipement en matériel biomédical et biotechnique.
- * Maintenance, aménagement et préparation du patrimoine immobilier et matériel.

- * Recherche et normalisation de l'infrastructure des équipements.
- * Gestion administrative, entretien des installations des services centraux et tenue des inventaires des patrimoines foncier et bâti du département.

Direction de la réglementation et du Contentieux

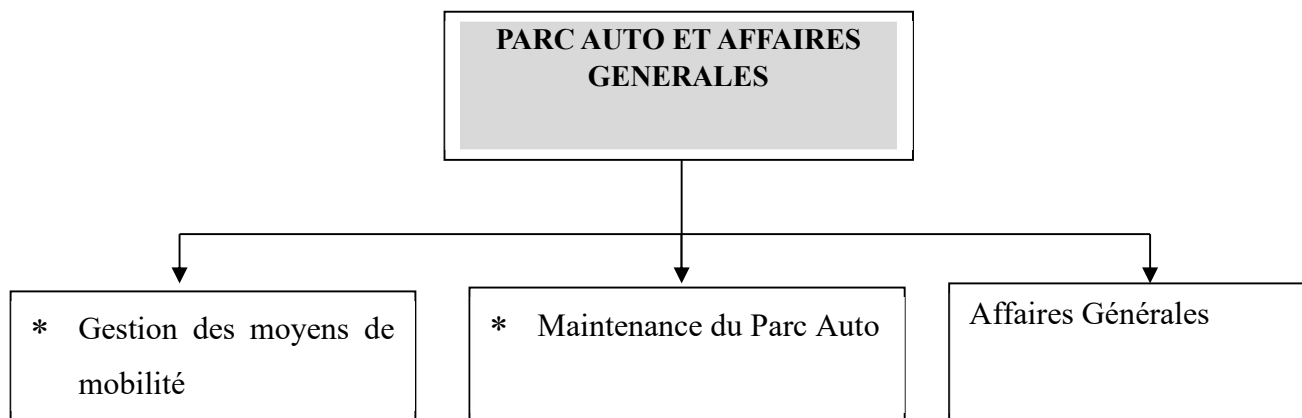


Attributions :

- * Etudes juridiques et élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de santé.
- * Instruction des dossiers contentieux impliquant le ministère.
- * Suivi administratif des relations du département avec les autres administrations, les collectivités locales et les associations nationales.
- * Participation au contrôle de l'exercice des professions réglementées.
- * Appui aux autres directions du ministère en matière juridique
- * La Direction de L'approvisionnement en Médicaments et en Produits De Santé (DAMPS)
- * Chargée de plusieurs missions, dont l'approvisionnement des établissements de santé en médicaments et en produits de santé de base de haute qualité ;

- * Exécution des dépenses communes des différentes directions ;
- * Acquisition, stockage et distribution des produits pharmaceutiques, des médicaments et des produits d'intendance.
- * La Direction de la Protection Sociale des Travailleurs (DPST)
- * Ses attributions sont relatives à la protection sociale en matière d'accidents de travail.

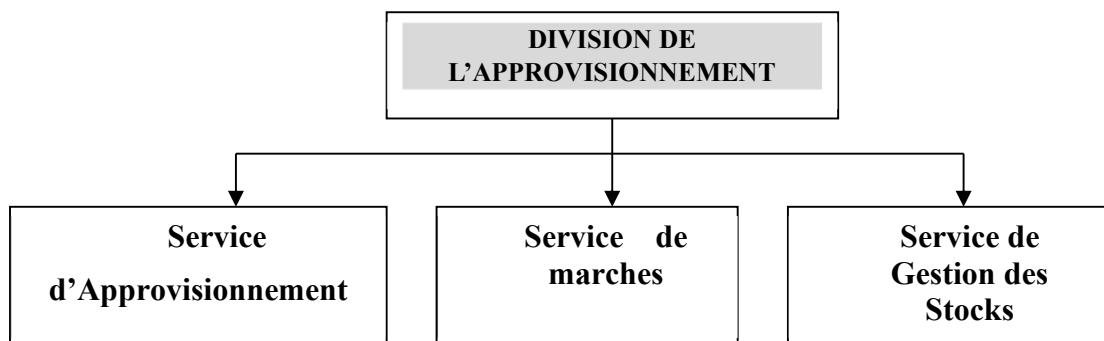
Division du Parc Auto et Affaires Générales



Attributions :

- * Gestion et maintenance du Parc auto et des moyens de mobilité du ministère.

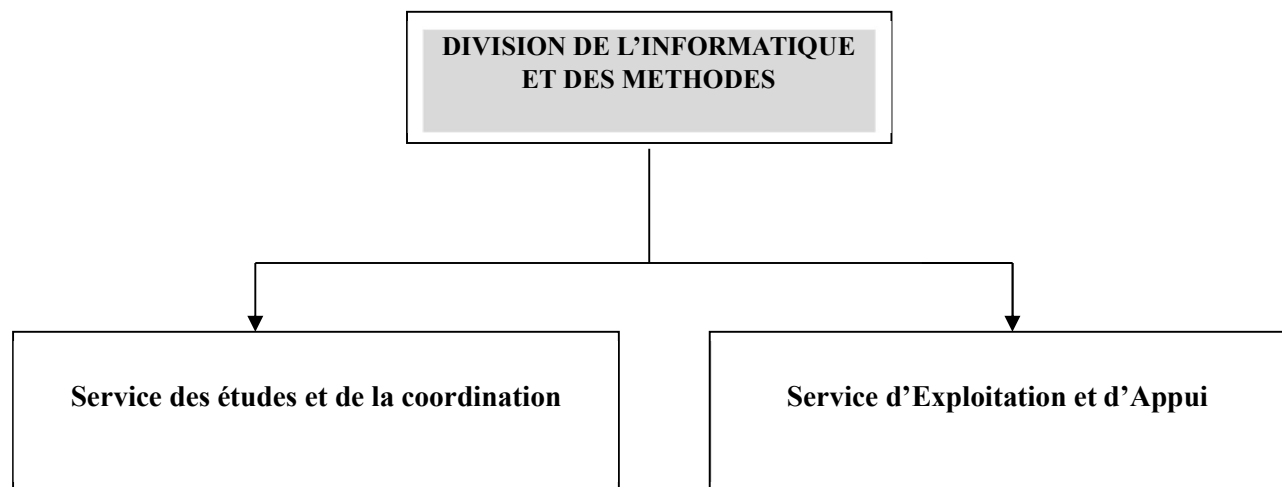
Division de l'Approvisionnement



Attributions :

- * Exécution des dépenses communes des différentes directions
- * Acquisition, stockage et distribution des produits pharmaceutiques, des médicaments et des produits d'intendance.

La Division de l'Informatique et des Méthodes



Attributions :

- * Animation des activités informatiques du ministère par l'élaboration et la gestion d'un schéma directeur.
- * Appui technique en matière d'information aux services centraux et aux services extérieurs.

3. Les services assimilés à des services centraux

- ✓ L'Institut National d'Hygiène (I.N.H)
- ✓ Le Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie (CNTSH)
- ✓ Le Centre National de Radioprotection
- ✓ L'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP)
- ✓ Le centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM)
- ✓ Le laboratoire national de Contrôle de médicament (LNCM)
- ✓ L'institut Pasteur Maroc (IPM) ou Centre de sérums et Vaccins (CSV)
- ✓ Le laboratoire national de virologie (LNV)

4. Organisation de l'administration périphérique : (Services extérieurs)

Les services déconcentrés du ministère de la santé sont constitués des directions régionales de la santé et des délégations préfectorales et provinciales, instituées respectivement dans les ressorts territoriaux des wilayas, de régions et des préfectures, préfectures d'arrondissements ou provinces,

A. Les directions régionales de santé :

Les directions régionales de la santé : **12 régions**

Les délégations préfectorales et provinciales de la santé : **82 délégations**

i. Définition

C'est l'organisation territoriale des services régionaux de santé répondant au souci de déconcentration. Sur le plan structural, la direction régionale créée dans chacun des chefs-lieux de régions constituerait le relais entre les délégations provinciales ou préfectorales et l'administration centrale. Elle sera investie² d'une mission de représentant du pouvoir central au niveau de la région.

ii. Mission des services extérieurs :

Les directions régionales de la santé ont pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de santé, au niveau des régions, en tenant compte des spécificités de celles-ci dans la limite de leurs ressorts territoriaux et des attributions qui leur sont déléguées par le ministre de la santé, les directions régionales de la santé ont notamment pour missions :

- 1.** La protection de la santé publique et la veille sanitaire.
- 2.** La planification stratégique.
- 3.** Le financement et la gestion financière.
- 4.** La gestion des ressources humaines.
- 5.** Le pilotage et la coordination des actions des établissements de santé.
- 6.** La garantie et la disponibilité, de la qualité et de l'accessibilité des médicaments et produits pharmaceutiques non médicamenteux.

Les directions régionales de la santé sont chargées, en outre, de l'animation et de la coordination des actions de santé au niveau régional en partenariat avec d'autres intervenants régionaux,

Charger solennellement, officiellement d'un pouvoir, d'un droit, d'une dignité.

notamment les administrations publiques, les collectivités locales, le secteur privé et la société civile

Organisation

Chaque direction régionale de la santé est gérée par un directeur nommé par le ministre de la santé.

Le directeur régional est le chef hiérarchique supérieur de l'ensemble du personnel de la direction régionale et du personnel des délégations du ministère aux préfectures et aux provinces de la région.

Il est chargé de :

- * La mise en œuvre des attributions dévolues à la direction régionale de la santé ;
- * La représentation du ministère au niveau de la région.

Chaque direction régionale de la santé est composée des services suivants :

1. Le service de la santé publique,
2. Le service de l'offre de soins,
3. L'observatoire régional de Santé,
4. Le service des ressources financières, logistique et partenariat,
5. Le service des ressources Humaines et du contentieux,
6. Le service des équipements et de la maintenance.

Chaque direction régionale de Santé comporte :

1. Une unité régionale des approvisionnements et de la pharmacie,
2. Une unité régionale de communication et d'information,

Les attributions des services constituant la direction régionale de la santé :

Les attributions des services de la direction régionale de la santé sont limitées par l'arrêté du ministre de la santé N° 003/16 du 4 janvier 2016.

1. La protection de la santé publique et la veille sanitaire ;
2. La planification stratégique ;
3. Le financement et la gestion financière ;
4. La gestion des ressources humaines ;

5. Le pilotage et la coordination des actions des établissements de santé ;
6. La garantie de la disponibilité, de la qualité et de l'accessibilité des médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux ;

a. Service de santé publique

- * Développement des programmes de la santé reproductive et de la santé maternelle et infantile et de leur mise en œuvre ;
- * La mise en œuvre et le développement des programmes de la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
- * Organisation et garanti de la surveillance épidémiologique et de la vigilance et la sécurité sanitaire
- * Contribution à la promotion et le développement des programmes de santé et de l'environnement
- * La promotion de la santé des personnes à besoins spécifiques et la coordination des activités des institutions médico -sociales publics ;
- * Contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région

b. Service de l'offre de soins

- * Organisation des réseaux des établissements de santé au niveau régional, ainsi que des structures d'appuis spécialisées et la coordination entre eux
- * Saisie de la base de données de l'Offre de soins régionale, et identification des besoins, compte tenu des textes législatifs et réglementaires en vigueur
- * Préparation du plan régional d'offre des soins et suivie de sa mise en œuvre
- * Veille à l'établissement, l'organisation et le suivi des réseaux et filière de soins
- * L'organisation et la coordination des activités des établissements sanitaires
- * Assurance de la qualité des activités sanitaires et la sécurité des patients dans les établissements sanitaires
- * Contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région

c. Observatoire régional de la santé

- * Collecte et analyse des informations sanitaires régionales et leur évaluation ;
- * Suivi des indicateurs sanitaires au niveau régional ;
- * Gestion du système d'information sanitaire au niveau régional ;

- * Préparer des rapports régionaux périodiques sur le développement de l'état de santé, l'offre de soins et les services sanitaires ;
- * Contribuer à la réalisation des études sur le domaine sanitaire au niveau régional ;
- * Gestion des Systèmes d'information et entretien de leur matériel ;
- * Contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région.

d. Service des ressources financières, de la logistique et du partenariat

- * Préparer et suivre le projet de budget -programme régional ;
- * La mise en œuvre et suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement régionaux ;
- * Prospecte et mobilise des ressources additionnelles dans le cadre de partenariat ;
- * Rendre disponible des moyens logistiques pour soutenir les activités sanitaires régionales ;
- * Gestion des contrats de partenariat au niveau de la région dans les limites des décisions déléguées ;
- * Suivi de la mise en œuvre des accords de partenariat et leur évaluation ;
- * Gestion du parc auto et son entretien ; Contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région.

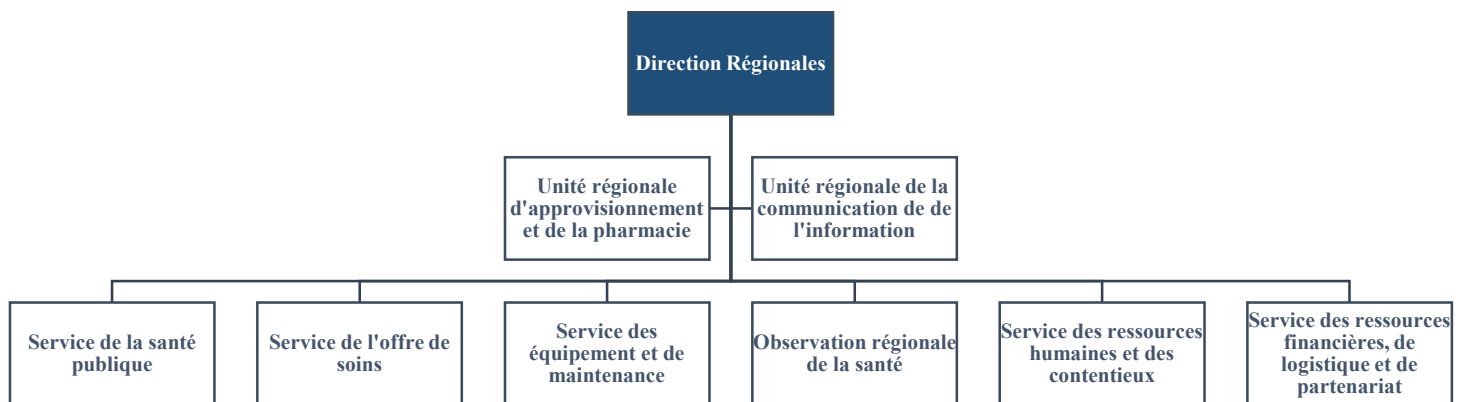
e. Service des ressources humaines et contentieux

- * Gestion des Ressources humaines dans les limites des décisions déléguées ;
- * Saisie d'une base de données informatique des Ressources humaines travaillant au niveau de la région ;
- * Identification des besoins de la région en ressources humaines et proposition des plans d'effectif du personnel ;
- * Veille à l'application du guide de référence des emplois et des compétences ;
- * Supervision de l'organisation et la mise en œuvre des programmes de formation continue pour les professionnels de santé ;
- * Développement des activités de santé et de sécurité au travail au profit des professionnels de santé de la région ;
- * Renforcement et suivi du dialogue social avec les représentants syndicaux et les partis sociaux au niveau de la région ;
- * Étude et suivi des dossiers des conflits

f. Service des équipements et de la maintenance

- * Programmation, mise en œuvre, et suivi des projets d'investissement liés à la santé dans la Région ;
- * Veille Sur l'entretien du patrimoine, des équipements et du matériel ;
- * Contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région

Organisation de la direction régionale de Santé



B. Les délégations provinciales et préfectorales :

i. Définition

- * C'est le niveau d'application et d'exécution de la politique de santé dont l'organisation interne et la compétence territoriale sont fixées par arrêté du Ministre de la santé.
- * Chaque délégation est placée sous l'autorité d'un délégué nommé par le ministre de la santé, parmi les médecins du ministère de la santé. Il est le supérieur hiérarchique de l'ensemble du personnel en fonction à la délégation, dans les services hospitaliers et les établissements de soins de santé primaires.
- * Il est chargé de la mise en œuvre des attributions définies ci-dessous et représente de ce fait, le ministre de la santé au niveau de la province ou la préfecture d'affectation.

Les attributions

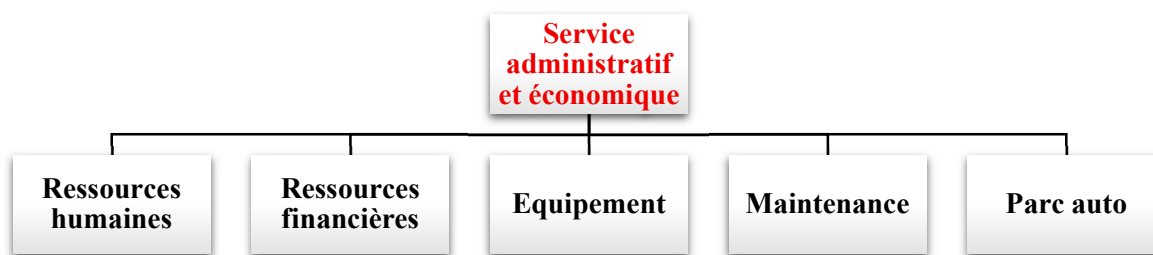
- * La supervision, la coordination, le contrôle et l'évaluation des actions de prévention et soins entreprises par les ESSP et CHP ;
- * La gestion des crédits de fonctionnement nécessaires à la réalisation des actions précitées ;

- * La collecte et l'exploitation des informations sanitaires ;
- * La gestion des ressources humaines ;
- * La contribution à l'élaboration des plans d'action de formation continue de ces ressources et veiller au suivi-évaluation de l'exécution de ces plans d'action ;
- * La promotion des relations de coopération avec les intervenants dans le domaine de la santé.

ii. Organisation et fonctionnement des délégations DMS :

Chaque délégation comprend les services suivants :

- * **Un service administratif et économique**, chargé de faciliter l'organisation, l'exécution et l'évaluation de toutes les tâches d'ordre administratif ou financier ;



- * **Le service du réseau des établissements sanitaires SRES**, chargé d'élaborer les plans d'action des ESSP au niveau de la province ou de la préfecture et de veiller à l'encadrement, au suivi et à l'évaluation de leur exécution, et la coordination des activités du RH, REMS et RISUM.

iii. Missions du SRES

- * Assurer l'encadrement et le bon fonctionnement du réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP), y compris son mode mobile dans le respect des territoires sanitaires fixés par la carte sanitaire.
- * Veiller à la coordination avec les réseaux des établissements de santé à travers la mise en place et le suivi des filières et réseaux coordonnés de soins pour assurer à la population des services de santé continus, intégrés et centrés sur la personne, la famille et la communauté.

iv. Attributions et organisation du SRES

- * Pour assurer sa mission et dans un but d'intégration des programmes et d'efficacités dans l'utilisation des ressources, le SRES sera organisé en quatre unités fonctionnelles ayant chacune des attributions distinctes et des profils adéquats. Chaque SRES est placé sous l'autorité d'un médecin chef.

a. Organigramme du SRES



b. Attributions du SRES

1. Unité de planification, suivi et évaluation des actions et programmes de santé.

- * Elaborer, suivre et évaluer le plan d'action provincial relatif aux actions et programmes de santé (fixe et mobile).
- * Encadrer et superviser les circonscriptions sanitaires et évaluer leurs performances
- * Identifier les besoins en formation des ESSP et contribuer à la dispensation de ces formations.
- * Collecter et analyser les données relatives aux actions des programmes de santé.
- * Produire les bilans et rapports périodiques relatifs aux actions et programmes de santé.
- * Mettre à jour la base de données relative au RESSP et le tableau de bord du SRES.

2. Unité de veille, sécurité sanitaire et de la santé environnementale.

- * Assurer la surveillance épidémiologique, la veille et sécurité sanitaire et coordonner les actions au niveau provincial ou préfectoral en collaboration avec l'ensemble des intervenants et ce conformément aux attributions définies par la circulaire ministérielle n° 47 du 17 juillet 2002.
- * Mettre en œuvre les programmes de santé environnementale.

3. Unité de coordinations des réseaux de santé.

Cette unité a pour mission de faciliter le parcours de soins des patients en coordonnant les actions de RESSP avec les autres réseaux notamment le REH mais aussi le REMS et le RISUM et ce dans le cadre d'un comité de coordination créé par le délégué du Ministère de la Santé à cet effet et composé des responsables des établissements des 04 réseaux.

- * Organiser et encadrer le système de référence – contre référence et assurer le suivi de l'implantation des filières et réseaux coordonnés de soins en collaboration avec les responsables des établissements de santé des autres réseaux.et spécialistes
- * Mettre en place les outils et mécanismes de facilitation du parcours de soins (réunions entre médecins généralistes, élaboration de procédures et critères de références et de contre références, système de prise rendez-vous à partir des ESSP.
- * Assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d'amélioration et décisions prises par le comité de coordination en vue de faciliter le parcours de soins.
- * Assurer le secrétariat du comité de coordination et établir les bilans et rapports des réalisations en termes de coordination.

4. Unité de la pharmacie.

Cette unité placée sous la responsabilité d'un pharmacien, a pour attributions de :

- * Assurer le bon déroulement du cycle de gestion des médicaments et autres produits de santé (achetés dans le cadre du budget de fonctionnement et des programmes de santé), depuis la commande jusqu'à la distribution, dispensation voire l'élimination en passant par la réception, le suivi de la traçabilité ainsi que la sécurisation de leur circuit.
- * Superviser le cycle de gestion des médicaments et autres produits de santé et en assurer l'usage rationnel.
- * Superviser l'activité de stérilisation au niveau des ESSP.
- * Encadrer et former le personnel impliqué dans la gestion et l'utilisation des médicaments et autres produits de santé.

V. Organisation de l'offre de soins au Maroc :

- * **Installation de santé** : le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle.
- * **Fixe** et correspondre à un établissement de santé.
- * **Mobile** comme les Unités Médicales Mobiles ou les moyens de transport sanitaire.
- * **Etablissements médico-sociaux** : des établissements de santé destinés à des catégories de populations vulnérables qui ont besoin d'un suivi médical régulier.
- * **Etablissements médico-sociaux** : les établissements de santé publics assurent une prise en charge médicalisée des personnes âgées, et de manière générale des personnes à besoins spécifiques.
- * **Installation de haute technologie** : installation utilisée dans une infrastructure ou une installation de santé, reposant sur une technologie et des techniques de pointe relevant des domaines des technologies de l'information, de la biotechnologie, de la robotique ou des nanotechnologies.
- * **Soins essentiels** : les soins requis pour prendre en charge de façon adéquate la majorité des problèmes de santé d'une population. Comprennent les soins de santé primaires et les principaux soins de recours hospitaliers de proximité.
- * **Prestations d'hôpital de jour** : Prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée, sans hébergement, si l'état de santé du patient le permet.
- * **Lit hospitalier** : Lit réservé à des soins d'hospitalisation complète d'une nuitée au moins.
- * **Place hospitalière** : Place réservée à des soins en hôpital de jour.
- * **Pôle d'excellence** : pôle d'une spécialité médicale ou chirurgicale très avancée dans un mode de prise en charge médicale, ou dans une technique médicale donnée
- * **Centre de référence interrégional** : centre de soins relevant d'un établissement de santé qui dispense des prestations de soins et de services de santé dans un territoire sanitaire qui dépasse le bassin de desserte dudit établissement. Il peut s'agir d'une prise en charge dans un domaine de spécialité ou de groupe de spécialités médicales, ou de prestations de soins liées à un matériel biomédical lourd ou à une installation de haute technologie

- * L'offre de soins est régie par le principe de gradation des niveaux de soins. Elle repose sur un système de référence et de contre référence, qui régule les parcours de soins des patients en dehors des situations d'urgence.
- * La loi 34-09 et son décret d'application consacrent et consolident le **modèle de système de soins préconisé par le Maroc qui est un système : Pyramidal, Intégré, Hiérarchisé et fondé sur les SSP**

Les 8 principes régissant l'offre de soins et la carte sanitaire

1. La solidarité et la responsabilisation de la population ;
 2. L'égalité d'accès aux soins et services de santé ;
 3. L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;
 4. La complémentarité intersectorielle ;
 5. L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé ;
 6. L'intégration et la coordination ;
 7. La globalité ;
 8. La gradation des soins.
- * Ce système peut être organisé à l'intérieur du même territoire de santé sous forme de :
 - **Réseau coordonné de soins** : une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire, afin de renforcer la coordination d'une prise en charge médicale multidisciplinaire faisant intervenir des professionnels de la santé relevant du secteur public et/ou privé.
 - **La filière de soins** : une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients à travers des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et les protocoles thérapeutiques quand ils existent, avec un premier contact d'accès aux soins, représenté par les médecins généralistes pour le secteur privé et par les établissements de soins de santé primaires pour le secteur public.
 - ✓ Outil de promotion de la qualité des soins (continuité, coordination) ;
 - ✓ Prévenir la surutilisation (encombrement) ou la sous-utilisation des services de santé ;
 - ✓ Préalable à la mise en place des protocoles thérapeutiques ;
 - ✓ Outil de facilitation de l'accès aux soins.

L'offre de soins au Maroc se décline en plusieurs modes :

1. Par secteurs : public, privé
 2. Par modes de couverture sanitaire : fixe, mobile
 3. Par territoires de santé (découpage sanitaire)
 4. Par réseaux d'établissements de santé : RESSP, RH, RISUM, REMS
 5. Par filières de soins et Par réseaux coordonnés de soins
 6. Par programme de santé
- Au Maroc **l'offre publique** de soins en **mode fixe** est composée des **quatre** réseaux d'établissements de santé suivants :
- Réseau hospitalier (**RH**).
 - Réseau des établissements de soins de santé primaires (**RESSP**).
 - Réseau intégré des soins d'urgence médicale (**RISUM**).
 - Réseau des établissements médico-sociaux (**REMS**).

L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public comprend, en outre, des structures spécialisées d'appui aux réseaux précités ainsi que des installations de santé mobiles, les équipements biomédicaux lourds et des installations de haute technologie

A. Le réseau hospitalier (RH) :

- Le réseau hospitalier est composé des établissements suivants :
 - Les Hôpitaux préfectoraux et provinciaux ;
 - Les Hôpitaux régionaux ;
 - Les formations hospitalières relevant des centres hospitaliers érigés en établissements publics (Centres hospitaliers universitaires « **CHU** » ou centres hospitaliers interrégionaux « **CHI** » ;
 - Les Hôpitaux psychiatriques ;
 - Les Centres régionaux d'oncologie ;
 - Les Centres d'hémodialyse.

- ❖ Le réseau hospitalier comprend en outre des structures spécialisées pour appuyer les établissements de santé précités.
- ❖ Lorsque la superficie d'une **province** sanitaire est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par la création **d'hôpitaux de proximité**
- ❖ Lorsque la taille d'une **préfecture** sanitaire est importante, son réseau hospitalier peut être renforcé par la création de **cliniques de jour**
- ❖ Les établissements relevant du réseau hospitalier assurent chacun selon son objet, les missions suivantes :
 - 1/ dispenser les prestations de soins et les services de la santé
 - 2/ concourir aux actions de formation médicale, odontologique, infirmiers, recherche...
- ❖ En fonction de son objet, chaque établissement relevant du réseau hospitalier participe dans le cadre des missions qui lui sont dévolues aux actions d'assistance médicale urgente en partenariat avec les acteurs concernés.

a. Définition d'un hôpital

« L'hôpital est un établissement sanitaire destiné à héberger des malades, des blessés ou des parturientes en vue de leur dispenser les prestations de soins, de diagnostic, de traitement et des soins d'urgence nécessités par leur état de santé. Il concourt à la formation pratique des étudiants en médecine et pharmacie et des élèves des écoles de formation professionnelle et de formation de cadres... »

b. Les missions d'un hôpital

D'après le décret n° 2-06-656 13 avril 2007 relatif à l'organisation hospitalière un hôpital a pour missions :

- **Mission de soins** : Le diagnostic, le traitement et l'hébergement.
- **Mission de développement professionnel** :
 - * La formation des médecins, infirmiers, techniciens et autres cadres.
 - * La formation continue des professionnels et des gestionnaires de santé.
 - * La recherche dans le domaine de santé.
 - * L'expertise.

- **Mission de santé publique :**

- * L'hôpital concourt aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé,
- * Il garantit la permanence des soins et assure des prestations de soins et d'aide médicale en urgence.

- **Mission économique et managériale :** Achat, gestion des productions et direction.

c. Organisation d'un hôpital

- * Tout hôpital, quel que soit ses dimensions, ses objectifs doit avoir une organisation qui lui permet de mener à bien sa mission.
- * Chaque hôpital est dirigé par un médecin directeur nommé par le ministre de la santé sur proposition du délégué de la préfecture ou de la province médicale concernée.

❖ **Attributions du directeur**

- * Le directeur du centre hospitalier ou de l'hôpital assure la gestion technique, administrative et financière de l'hôpital. Il est responsable de la conduite générale de l'établissement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du présent règlement intérieur.
- * Il est responsable de la mise en œuvre de la politique sanitaire et des directives ministérielles en matière de planification, de gestion hospitalière et veille au bon fonctionnement de l'établissement.

A ce titre, Il est notamment chargé de :

- Veiller à la planification des actions de l'établissement dans le cadre du « Projet d'établissement hospitalier » ;
- Veiller au respect et à l'application des plans d'actions et des normes et procédures de gestion hospitalière ;
- Coordonner les plans d'actions des différents départements et services hospitaliers pour atteindre les objectifs stratégiques de l'établissement ;
- Assurer la coordination des activités de l'ensemble des pôles, des départements, des services médicaux ou médico-techniques et s'assurer de la cohérence de leurs activités avec les missions et les objectifs de l'établissement et les ressources disponibles ;

- S'assurer que les unités de soins et services évaluent de façon systématique et continue la qualité des actes professionnels ;
- Veiller à l'exécution des recommandations du « comité d'établissement » de l'hôpital ;
- Approuver les listes de garde et d'astreinte ;
- Élaborer une stratégie de communication interne et externe et soutenir les différents services de l'établissement dans l'élaboration de leurs plans de communication spécifiques ;
- Représenter l'établissement vis-à-vis des partenaires, des usagers et des tiers en concertation avec le délégué ;
- Coordonner les relations de l'établissement avec les autres composantes de la filière de soins en concertation avec le délégué ;
- Informer la hiérarchie de tout incident important ou grave qui survient à l'intérieur de l'établissement ;
- Établir un rapport annuel des activités techniques, administratives et financières de l'établissement ;
- Gérer les relations de travail avec les différentes instances syndicales locales ;
- Mettre à jour annuellement les inventaires de l'hôpital ;
- Élaborer le projet de budget annuel et les projets de budgets programmes et veiller à leur exécution.

❖ **Attributions et organisation des pôles de gestion**

L'administration du centre hospitalier et de chaque hôpital est organisée en trois pôles de gestion :

- * Un pôle des affaires médicales (PAM) ;
- * Un pôle des soins infirmiers (PSI) ;
- * Un pôle des affaires administratives (PAA).
- **Le pôle des affaires médicales (PAM) ;**
Le pôle des affaires médicales est placé sous la responsabilité d'un médecin. Il est chargé des missions suivantes :
 - * La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services médicaux, y compris ceux relatifs à l'éducation sanitaire ;
 - * L'évaluation de la qualité et de la performance des soins hospitaliers ;
 - * La formation continue du personnel médical ;

- * La contribution à la formation continue du personnel paramédical ;
- * La contribution à la prévention des infections et à l'hygiène de l'établissement ;
- * La planification et la gestion des ressources destinées au personnel médical ;

Le pôle des affaires médicales est organisé en deux ou plusieurs bureaux en fonction du volume des activités

■ **Le pôle des soins infirmiers (PSI) ;**

Le pôle des soins infirmiers est placé sous la responsabilité d'un cadre titulaire du diplôme d'état d'infirmier. Il a pour mission de veiller à la bonne gestion des unités de soins et de services paramédicaux. A cet effet, il est notamment chargé des activités suivantes :

- * La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux,
- * L'évaluation de leur qualité et performance,
- * La contribution à la prévention des infections nosocomiales ;
- * La planification et la gestion des ressources destinées au personnel paramédical ;
- * La contribution à l'élaboration et au suivi des programmes d'éducation sanitaire ;
- * La contribution au développement de la recherche en soins infirmiers ;

Le pôle des soins infirmiers est structuré en deux ou plusieurs bureaux en fonction du volume des activités

■ **Le pôle des affaires administratives (PAA).**

Le pôle des affaires administratives est placé sous la responsabilité d'un cadre administratif, il a pour mission d'assurer la gestion des ressources humaines et financières ainsi que la gestion des services techniques et de maintenance. Il apporte son appui à l'ensemble des différents services de l'établissement.

Le pôle des affaires administratives est chargé des activités suivantes :

(a) En matière de gestion des ressources humaines :

- * Assurer la gestion administrative du personnel ;
- * Élaborer le plan de développement des ressources humaines ;
- * Élaborer des stratégies de mobilisation et de motivation du personnel ;
- * Veiller à la bonne application du système d'appréciation du rendement du personnel ;
- * Élaborer le plan d'action de la formation continue du personnel du pôle.

(b) En matière de gestion administrative, des ressources financières :

- * Assurer la gestion budgétaire, financière et comptable ;
- * Assurer l'approvisionnement en médicaments, fongibles, matériel et autres produits nécessaires au fonctionnement de l'établissement et en assurer leur distribution ;
- * Veiller au recouvrement des créances de l'établissement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- * Organiser et gérer les archives administratives de l'établissement.

(c) En matière de gestion des services techniques et de soutien :

- * Assurer l'alimentation des patients et du personnel de garde ;
- * Assurer le nettoyage et la sécurité des bâtiments et les bandages des linges ;
- * Gérer le système interne de télécommunication ;
- * Assurer la gestion des déchets hospitaliers ;
- * Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion et de maintenance des équipements médicaux, des installations techniques, des bâtiments et mobiliers ainsi que du parc automobile.

Le pôle des affaires administratives est organisé en bureaux ou unités en fonction du volume de ses activités.

❖ Instances de concertation et d'appui

La direction de l'hôpital est assistée par des instances de concertation et d'appui qui ont un rôle de concertation et de proposition et qui sont :

Deux instances de planification et de coordination :

1. **Le comité d'établissement** : sa mission est de définir les orientations stratégiques de l'hôpital ex : projet d'établissement, projets de contrat programme et les programmes d'investissement.....
2. **Le comité de gestion du centre hospitalier** : il est créé dans chaque centre hospitalier régional, provincial ou préfectoral, présidé par le délégué du ministère de la santé à la province ou préfecture.

Deux instances de conseil et de concertation :

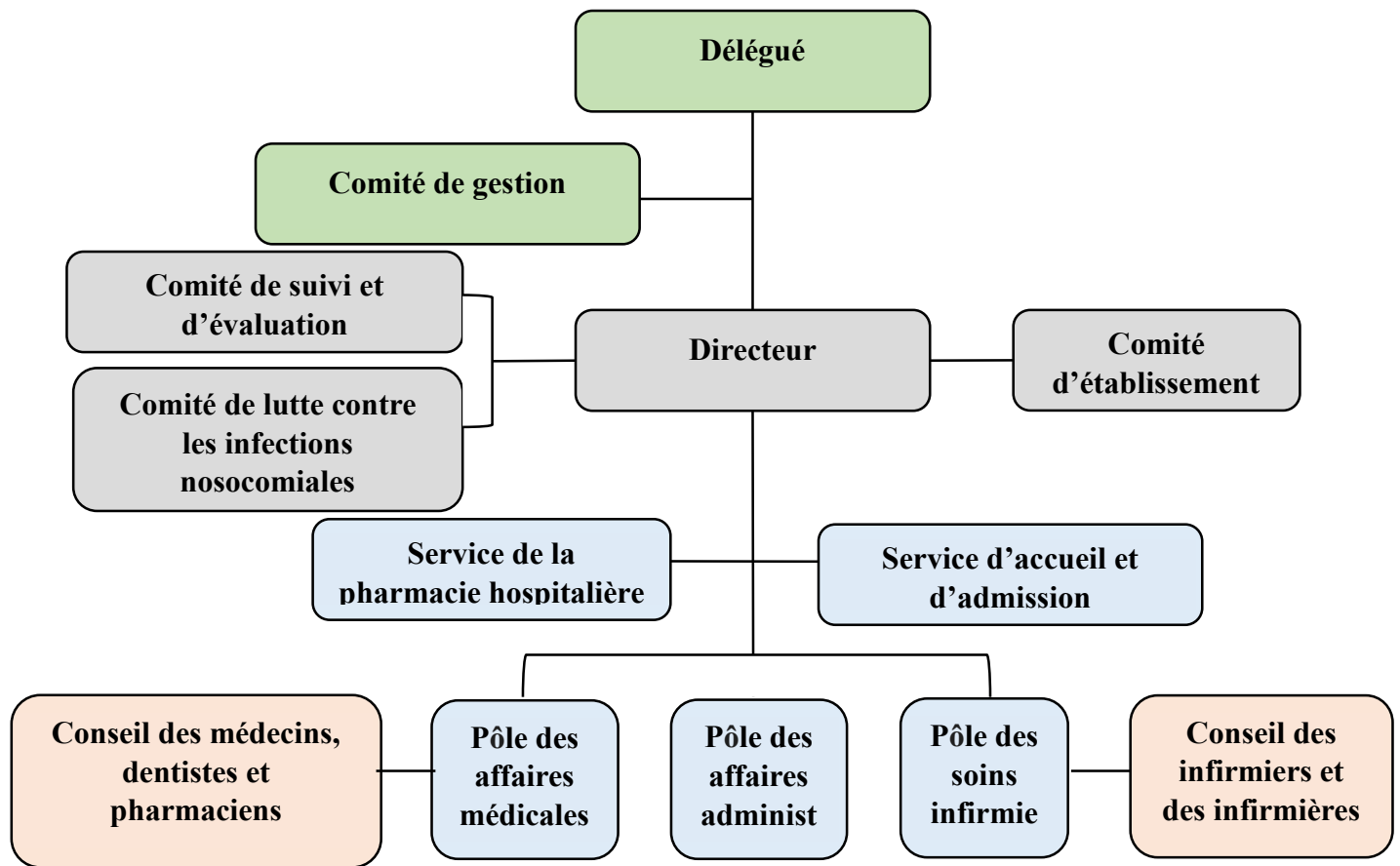
- 1. Le conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens (CMDP) :** composé des représentants élus des médecins, des dentistes et des pharmaciens. Il propose des recommandations sur le fonctionnement de l'hôpital.
- 2. Le conseil des infirmiers et infirmières (CII) :** composé pour la moitié du responsable du pôle soins infirmiers, des infirmiers (res) chefs de départements et des infirmiers (es) chefs de services et pour l'autre de représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux. Les membres du conseil élisent, parmi ceux, un président sur la base de sa notoriété professionnelle. Le conseil est chargé de :
 - Apprécier la qualité et la pertinence des soins infirmiers.
 - Contribuer à la formation continue.
 - Donner son avis sur les questions relatives à la prestation des soins infirmiers par l'hôpital, qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement.

Deux instances d'appui :

- 1. Le comité de suivi et d'évaluation :** assure le suivi des activités cliniques et informationnelles, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que l'analyse de la performance de l'hôpital et de la qualité des soins.
- 2. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) :** il est chargé de mener les activités de lutte contre les infections nosocomiales et d'établir à la direction un rapport périodique de la situation sur la lutte contre ces dernières et de veiller à sa diffusion.

Les instances de concertation en matière de la santé :

1. Un conseil national consultatif de la santé ;
2. Un comité national d'éthique ;
3. Une commission nationale consultative de coordination entre le secteur public et le secteur privé ;
4. Une commission nationale et des commissions régionales de l'offre de soins ;
5. Un comité national de veille et de sécurité sanitaires ;
6. Un comité national d'évaluation et d'accréditation



d. Classification des hôpitaux :

Les hôpitaux sont classés selon :

- * L'orientation technique ou spécialisation.
- * Le niveau d'intervention ou niveau de recours.
- * Le mode de gestion ou statut.
- * La capacité litière

i. Selon l'orientation technique :

On distingue deux types d'hôpitaux :

* **L'hôpital général (HG) :**

Qui est un établissement sanitaire qui assure une série des services différenciés à des malades de tout âge et souffrant d'affections diverses. Il dispose de services médicaux techniques d'investigation, de traitement et d'hospitalisation. Il comprend outre le service des **urgences**, les

disciplines de base suivantes : **chirurgie, médecine, obstétrique, pédiatrie**. Il peut aussi comprendre d'autres spécialités médicales et chirurgicales.

*** L'hôpital spécialisé :**

Qui est un établissement sanitaire qui s'occupe essentiellement des personnes souffrant d'une maladie déterminée ou d'une affection d'un appareil ou d'un organe donné. Ce type d'hôpital reçoit généralement les malades ayant besoin des soins spéciaux, orientés par un établissement sanitaire où ils ont été vus auparavant.

ii. Selon le lieu d'implantation :

*** Le premier niveau.**

*** L'hôpital de proximité : 70 000 Habitants**

C'est un hôpital général dans lequel s'exerce la médecine, la chirurgie générale, la pédiatrie, l'obstétrique et une activité d'urgences .il est implanté au chef-lieu d'un cercle administratif (**au moins 70000 habitants**), il constitue dans le site où il est implanté le premier niveau de référence pour les établissements des soins de santé primaires qui sont dans son rayon d'influence. (Moins de 60 lits).

*** Le centre hospitalier provincial ou préfectoral (CHP) : 200 000 Habitants**

Implanté au chef-lieu de la province (**minimum 200 000 habitants**). Il est constitué par l'ensemble des établissements hospitaliers relevant du ministère de santé implantés dans son territoire, y compris les hôpitaux de proximité ou les cliniques de jour.

Sa capacité et la dimension de son plateau technique varie avec la nature des disciplines qui y sont développées et selon l'importance de la population à desservir.

Il dispense les prestations de soins hospitaliers de premier niveau : comporte en plus des disciplines de base, les spécialités médicales et chirurgicales suivantes : l'ophtalmologie, la dermatologie vénérologie-léprologie, les maladies infectieuses, l'oto-rhino-laryngologie, la psychiatrie, la pneumo-phtisiologie, la cardiologie, la néphrologie, la gastro-entérologie, la réhabilitation, l'endocrinologie, stomatologie et la réanimation médicochirurgicale.

* **Le deuxième niveau.**

* **Le centre Hospitalier Régional (CHR) : Territoire régionale**

Il est constitué par un ou plusieurs hôpitaux généraux et spécialisés. Sa capacité et la dimension de son plateau technique varient selon l'importance de la population à desservir et la nature des disciplines qui y sont développées. Il comprend en plus des disciplines existantes au niveau du CHP des disciplines à vocation régionales telles que la chirurgie infantile, l'hématologie l'urologie, la néphrologie, la neurochirurgie, la rhumatologie, la médecine interne, l'oncologie et la neurologie.

* **Le troisième niveau**

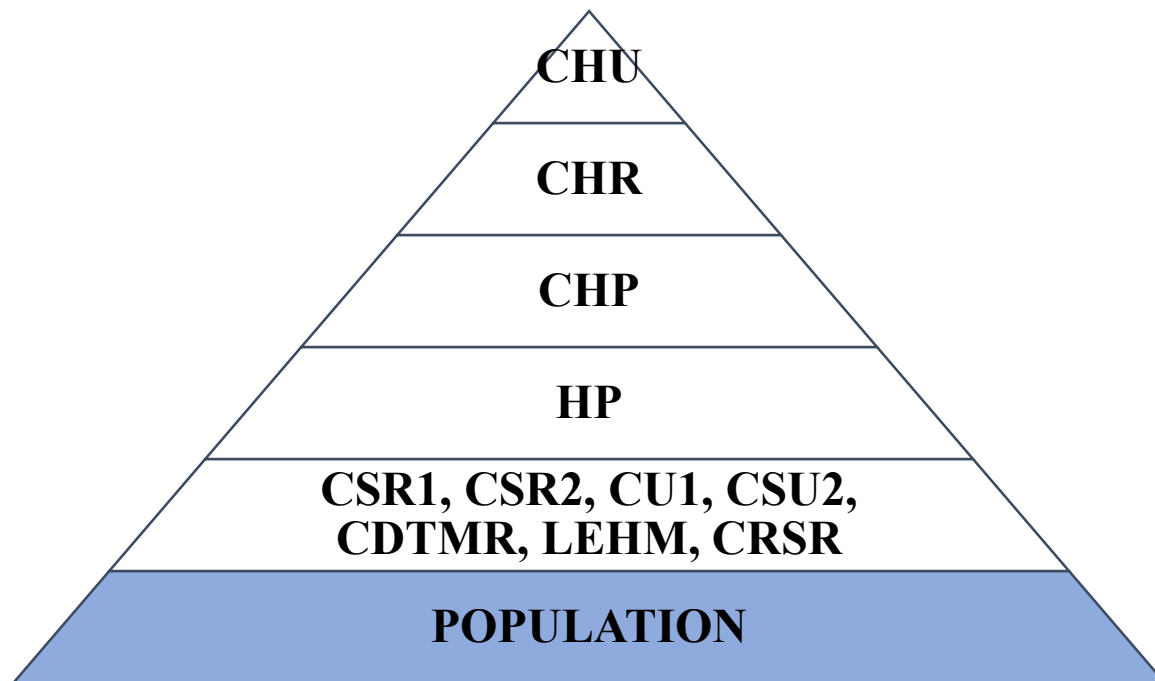
* **Le Centre Hospitalier inter-régional : (Centre Hospitalier Universitaire) « CHU »**

02 régions ou 2 millions Habitants

Il est constitué d'un ensemble d'établissements comprenant une gamme complète de services hautement spécialisés (pôles d'excellence). Le CHU est un centre d'enseignement et de recherche, son aire d'influence s'étend aux moins sur **deux régions et couvrir une population près de deux millions d'habitants.**

Il comporte en plus des disciplines existantes au niveau du CHR, les disciplines qui ont un caractère national telles que la cancérologie, chirurgie traumatologique, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardio-vasculaire et l'hématologie clinique

DR	< 7 000 hbs	HP	70 000 hbs
CSR1	7 000 hbs	CHP	200 000 hbs
CSR2	25 000 hbs	CHR	Région
CSU1	25 000 hbs	CHU	2 millions hbs
CSU2		50 000 hbs	



iii. Selon le mode de gestion :

➤ **Les hôpitaux dits « en régie » ou SEGER (services de l'Etat gérés en régie) :**

- * Dépendance statutaire et financière du ministère de la santé.
- * Ne disposent pas de personnalité morale et liés au programme d'exécution du MS.
- * Leurs ressources financières sont des crédits délégués par le département sur budget général.
- * Pas de virement de crédits d'un article à l'autre.

➤ **Les hôpitaux érigés en service de l'Etat géré de manière autonome (SEGMA) :**

- * Ne jouissent pas d'une personnalité morale.
- * Ce sont des services dotés d'une autonomie financière.
- * Ils peuvent réutiliser leurs recettes.
- * Leurs dépenses obéissent aux règles de la comptabilité publique.
- * Formule intermédiaire entre gestion en régie et la gestion autonome.
- * Bénéficie d'une subvention de l'Etat.
- * Ils sont soumis à la subordination de l'administration sanitaire.

« Les SEGMA sont des services de l'Etat dont les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie sont exécutées par un chef de service sous ordonnateur à plein droit et par un comptable public spécial rattaché au comptable supérieur de royaume ».

*** Les Centres Hospitaliers Erigés en Etablissements Publics Administratifs (CHEEPA) :**

- * Jouissent d'une personnalité morale et juridique. (Droit public).
- * Sont des services dotés d'une autonomie financière.
- * Peuvent effectuer des virements de crédits d'un article à un autre mais dans un même chapitre.
- * Peuvent réutiliser leurs recettes.
- * Peuvent recevoir des dons et des legs.
- * Ils sont soumis à un certains contrôles de l'Etat et au respect des principes fondamentaux du service public. (Tutelle).

Les centres hospitaliers concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'Etat en matière de santé.

iv. Selon la capacité d'accueil :

Le Règlement Intérieur des Hôpitaux consacre la capacité d'accueil (la taille) comme critère d'organisation des soins (départements et services) :

 3 catégories d'hôpitaux :

< 120 lits	08 services
120 à 240 lits	06 départements et 03 services
> 240 lits (20 hôpitaux)	08 départements et 02 services

Formule de calcul de la capacité litière :

$$L = \frac{P \times TA \times DMS}{365 \times TOM}$$

- * **L** : Le nombre de lit à prévoir (Capacité litière).
- * **P** : Effectif de la population à desservir.
- * **TA** : Taux d'admission (fixé à 7%).

* **DMS** : Durée moyenne de séjour. (Fixée à 5 jours).

* **TOM** : Taux d'occupation moyenne. (Fixé à 80%).

e. Organisation des prestations de soins et de services

- * Les activités médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont organisées au sein d'unités de soins et de services formant. Soit des départements, soit des services médicaux
- * Le département ou le service médical réunit des unités de soins et de services d'une même spécialité ou de spécialités différentes qui partagent le même plateau technique, ou qui s'adressent à la même population cible, ou qui nécessitent une organisation commune.
- * Un service médical peut être médical, chirurgical ou médico-technique. Les unités de soins et de services sont créées sur proposition du comité d'établissement en fonction des prestations à offrir aux. Patients hospitalisés et de l'organisation optimale des soins.
- * L'organisation médicale des hôpitaux est conditionnée par leurs capacités litière ainsi on peut constater que les hôpitaux sont organisés de la manière suivante :

TYPE DE L'HÔPITAL	ORGANISATION
Les hôpitaux Généraux de Moins de 120 lits	Sont organisés en 08 services : • Le service d'accueil et d'admission (SAA) • Le service des urgences (SU) • Le service mère-enfant (SME) • Le service de médecine (SM) • Le service de chirurgie (SC), y compris le bloc opératoire • Le service d'imagerie médicale • Le service de biologie médicale • Le service de la pharmacie hospitalière
Les hôpitaux	Sont organisés en 6 départements cliniques et 3 services : • Le département mère-enfant (DME) • Le département de médecine (DM)

Généraux de 120 à 240 lits	• Le département de chirurgie (DC) • Le département de traumatologie-orthopédie et de neurochirurgie • Le département Ophtalmo – ORL – Stomatologie • Le département médico-technique (DMT) regroupant notamment les unités médico-techniques suivantes : - L'imagerie médicale - La biologie médicale - L'exploration fonctionnelle • Le service de la pharmacie hospitalière (SPH) • Le service d'accueil et d'admission (SAA) • Le service des urgences (SU)
Les hôpitaux De plus de 240 lits	Peuvent dépasser 8 départements cliniques - Les urgences doivent être intégrées dans un département clinique dans le respect de la cohérence des activités médicales et chirurgicales. Ils doivent en outre comprendre : • Le service d'accueil et d'admission (SAA) • Le service de la pharmacie hospitalière (SPH)

f. Les structures d'appui du réseau hospitalier :

- * Le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie.
- * Les laboratoires de l'institut national d'hygiène.
- * Le centre national antipoison et de pharmacovigilance.
- * Le centre national de radioprotection

Le panier de soins :

Hôpital de proximité	5 Spécialités
CHP	20 Spécialités
CHR	28 Spécialités
CHU ou CHIR	40 Spécialités

B. Le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP) :

Le Réseau des Etablissements de Soins de Santé Primaires est un réseau des services de santé de première ligne ou premier échelon ou premier niveau, conçu pour agir sur les conditions des habitants, c'est la base opérationnelle de toute l'action sanitaire. Il constitue la première interface entre la population et le système de soins. C'est à travers ce réseau que se développe la stratégie de la couverture de la population par les services de santé de base (promotion de la santé, prévention, soins essentiels).

Le Réseau des Etablissements de Soins de Santé Primaires est constitué de :

- * **En milieu rural**, par les centres de santé ruraux de premier niveau, les centres de santé de deuxième niveau et les dispensaires ruraux.
- * **En milieu urbain**, par les centres de santé urbains de premier niveau et les centres de santé urbains de deuxième niveau.
- * En plus de structures spécialisées d'appui aux soins de santé primaires.
- * La création et l'implantation des infrastructures et des installations de santé, ainsi que des équipements biomédicaux lourds sont décidées dans le cadre de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins selon des normes et des critères relatifs notamment

- ☐ Au découpage sanitaire,
- ☐ À la taille de la population et
- ☐ À l'attractivité socio-économique.

Les 6 fonctions des ESSP

- * Fonction de **soins**
- * Fonction de **santé publique**
- * Fonction d'**organisation et de gestion**
- * Fonction de **formation et d'encadrement**
- * Fonction de **communication et liaison**
- * Fonction de **développement communautaire et collaboration intersectorielle**

➤ En milieu rural :

1. Le dispensaire rural :

C'est le plus petit établissement de soins de santé de primaires. Il constitue l'unité opérationnelle de premier recours, non médicalisé, la plus décentralisée du système sanitaire devant délivrer des soins de santé essentiels (promotion, prévention et soins). Son implantation est prévue lorsque le territoire de desserte du centre de santé rural de premier niveau est étendu et il est placé sous la responsabilité d'un (e) infirmier (e).

2. Le centre de santé rural de premier niveau :

Définition :

Le centre de santé rural de premier niveau est un établissement de soins de santé primaires de premier contact en milieu rural. Il est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un (e) infirmier (e) major.

Fonctions :

Il offre des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent, en plus de la surveillance épidémiologique, notamment :

- * Les consultations de médecine générale.
- * Les prestations de soins infirmiers.
- * Le suivi de la santé de la mère et de l'enfant.
- * Le suivi des maladies chroniques.

- * Le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire.
- * Les prestations d'information et d'éducation pour la santé.

☞ Le centre de santé rural de premier niveau dessert une **population minimale de 7000 habitants.**

☞ La création et le lieu d'implantation de chaque centre de santé rural de premier niveau sont décidés dans le cadre du schéma régional de l'offre de soins.

☞ Lorsque le centre de santé rural de premier niveau dessert une population importante et des localités étalées sur de grandes superficies, il est possible de créer en plus dudit centre, un ou deux dispensaires ruraux qui lui seront rattachés.

3. Le centre de santé rural de deuxième niveau :

Définition :

Le centre de santé rural de deuxième niveau est un centre de santé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un (e) infirmier (e) major.

Fonctions :

En plus, des prestations fournies par le centre de santé rural de premier niveau, ledit centre assure notamment :

- * Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ;
- * Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ;
- * Les examens d'échographie obstétricale ;

Lorsque le centre de santé rural de deuxième niveau est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière, le centre est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et délivre en plus :

- * Des prestations d'urgence médicale de proximité,
- * Des soins bucco-dentaires ;
- * Des consultations de santé mentale ;

Le centre de santé rural de deuxième niveau dessert une **population minimale de 25000 habitants.**

➤ **En milieu urbain :**

1. Le centre de santé urbain de premier niveau :

Définition :

Le centre de santé urbain de premier niveau est un établissement de soins de santé primaires de premier contact en milieu urbain. Il est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un (e) infirmier (e) major.

Fonctions :

Il offre des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent, en plus de la surveillance épidémiologique, notamment :

- * Les consultations de médecine générale.
- * Les prestations de soins infirmiers.
- * Le suivi de la santé de la mère et de l'enfant.
- * Le suivi des maladies chroniques.
- * Le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire.
- * Les prestations d'information et d'éducation pour la santé.

☁ La création et le lieu d'implantation de chaque centre de santé urbain de premier niveau sont décidés dans le cadre du schéma régional de l'offre de soins.

☁ Le centre de santé urbain de premier niveau dessert une **population minimale de 25000 habitants.**

2. Le centre de santé urbain de deuxième niveau :

Définition :

Le centre de santé de deuxième niveau est un centre de santé placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un (e) infirmier (e) major.

Fonctions :

Le centre de santé urbain de deuxième niveau assure en plus des prestations fournies par le centre de santé urbain de premier niveau :

- 🏠 Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ;
- 🏠 Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ;

Lorsque le centre de santé urbain de deuxième niveau est implanté dans le chef-lieu de la commune urbaine de rattachement, ledit centre délivre en plus :

- 🏠 Les soins bucco-dentaires ;
- 🏠 Les consultations de santé mentale ;
- 🏠 Les prestations d'urgence médicale de proximité

Le centre de santé urbain de deuxième niveau dessert une **population minimale de 50000 habitants**.

➤ Les structures spécialisées d'appui :

Les établissements de soins de santé primaires, urbains ou ruraux, sont appuyés par des structures spécialisées qui assurent les activités relevant de certains programmes sanitaires, ces structures sont :

▪ Le centre de référence de la santé reproductive (CRSR) :

C'est une structure d'appui des établissements sanitaires de soins de santé primaires délivrant un paquet d'activités intégrées en santé reproductive. Il constitue le premier niveau de référence à partir des centres de santé et du secteur privé pour de nombreuses prestations de santé reproductive, telles que : le diagnostic précoce des cancers du sein et du col utérin. La prise en charge des cas compliqués de planification familiale et de certaines infections sexuellement transmissibles rebelles au traitement.

▪ Le centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR) :

C'est un établissement sanitaire qui s'occupe essentiellement des problèmes de prise en charge des cas de tuberculose et des maladies respiratoires et appuie les établissements de soins de santé primaires qui interviennent dans le programme de lutte antituberculeuse.

- **Le laboratoire de santé publique (Laboratoire d'épidémiologie et d'hygiène du milieu : LEHM) :**

Il a pour mission de soutenir les programmes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, notamment pour les aspects liés aux contrôles de certains produits à risque et au diagnostic biologique et immunologique des maladies faisant l'objet d'un programme structuré de lutte.

- **Autres structures d'appui :**

Selon les besoins de la population et de l'organisation des soins, le ministère de la santé peut mettre en place d'autres structures d'appui tels que :

- * Centre de dépistage des cancers féminins
- * Centre de référence des maladies chroniques
- * Centre de référence en santé scolaire et universitaire

C. Réseau intégré des soins d'urgences médicales (RISUM) :

a. Mission :

Permettre aux malades, blessés, femmes enceintes et parturientes en état de détresse, une assistance médicale urgente, soit par le conseil, soit par l'orientation vers la structure sanitaire adaptée ou par la prise en charge médicale au moyen d'un vecteur adapté dans les meilleurs délais.

Le RISUM est sous la responsabilité du **Directeur Régional**, il assure sa coordination et son évaluation en vue d'un fonctionnement intégré et complémentaire de l'ensemble de ses composantes.

Le Directeur régional assure la coordination du RISUM par le biais du **CRUM** (Comité Régional des Urgences Médicales) : examine les données et les indicateurs en que de proposer des améliorations continues du dispositif.

b. Principes généraux de fonctionnement

- * **La complémentarité** entre les RISUM en fonction de leurs ressources.
- * **L'interopérabilité** interrégionale : capacité à fonctionner ensemble et selon les mêmes normes.
- * **La synergie** entre les différentes composantes de chaque RISUM.
- * **La polyvalence** des ressources humaines exerçant au niveau des différentes unités composant le RISUM.

Les fonctions de soins d'urgence médicale sont définies selon :

- * Le niveau de l'offre de soins existante,
- * L'absence de structure hospitalière,
- * La population desservie
- * La distance vers l'hôpital de référence.

c. Composantes du RISUM pour la région

- * Les Services d'urgences hospitalières (SUH) ;
- * Le Service d'Assistance Médicale Urgente (SAMU) avec son Centre de Régulation des Appels Médicaux (CRAM) et son Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU). Cette structure pouvant être commune à plusieurs régions ;
- * Les Services Mobiles Hospitaliers d'Urgence et de Réanimation dits SMUR ;
- * Les Structures de Soins de Santé de Base participant aux activités médicales urgentes ;
- * Les moyens de transport sanitaire mobilisés par le CRAM dans le cadre de l'activité d'Assistance Médicale Urgente (AMU).

d. Modes d'intervention du RISUM :

Le **RISUM** accomplit sa mission selon les **trois modes** suivants :

1. **Les urgences médicales de proximité (UMP)** : assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux des cercles.
2. **Les urgences pré-hospitalières (UPH)** : assurées par les moyens de transport de secours de base, les services médicaux d'urgence et de réanimation (**SMUR**) et les services médicaux hélicoptés (**HELISMUR**).
3. **Les urgences médico-hospitalières (UMH)** : qui comprennent les urgences médico-hospitalières de base assurées par les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux, les

urgences médico-hospitalières complètes assurées par les centres régionaux et les urgences médico-hospitalières spécialisées assurées par les centres hospitaliers interrégionaux.

Le **RISUM** accomplit sa mission selon les **trois niveaux** :

7. Les urgences médicales de proximité (CS2)
8. Les urgences médico-hospitaliers de base (CHP)
9. Les urgences médico-hospitaliers complètes (CHR)

Les fonctions :

Les urgences médicales de proximité (UMP) : 07 fonctions

1. Permanence 24/24h
2. Diagnostic clinique des détresses vitales
3. Gestes et manœuvres de premier secours
4. Contention provisoire et immobilisation de fractures par attelles : minerves, attelles
5. Surveillance du patient
6. Examen biologique de base
7. Transfert sanitaire simple 24/24

Les urgences médico-hospitaliers de base (UMHB) : 05 fonctions

1. Gestes de ressuscitation et de réanimation
2. Examen complémentaire de Base
3. Transfusion
4. Hospitalisation
5. Intervention chirurgicale

Les urgences médico-hospitalières complètes (UMHC) :

1. Fonction de réanimation hospitalière polyvalente
2. Examens complémentaires complets :
3. Transfert SMUR en plus de F9 ;
4. Régulation des appels médicaux.

SAMU :

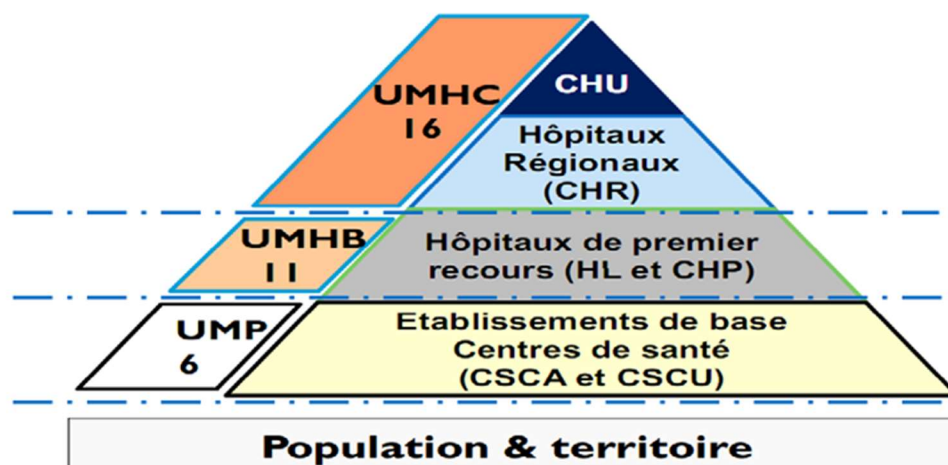
Service public hospitalier chargé de la réception et de la régulation des appels d'urgence et de détresse et de la gestion des urgences médicales préhospitalières et hospitalières.

Missions :

- ❖ Assurer une écoute médicale permanente
- ❖ Déterminer et déclencher la réponse mieux adaptée à la nature des appels
- ❖ Veiller à l'admission du patient
- ❖ Organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé
- ❖ La réponse médicale adaptée à l'état de santé du patient

Ses composantes :

- ❖ Centre de régulation des appels médicaux (CRAM)
- ❖ Centre d'Enseignement au Soins d'Urgence (CESU);
- ❖ Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR).



D. Le réseau des établissements médicaux-sociaux (RESMS) :

- ❖ La mission du réseau des établissements de santé médico-sociaux (RESMS) est la prise en
- ❖ Charge médicale avec un accompagnement social des personnes à besoins spécifiques.
- ❖ Les établissements médico- sociaux sont créés dans le cadre du schéma régional de l'offre de soins, soit par le ministère de la santé soit en partenariat avec d'autres acteurs publics ou privés.
- ❖ Les prestations dispensées par lesdits établissements peuvent être avec ou sans hébergement.

Composantes du REMS :

- * Centres dits espaces « santé-jeunes » ;
- * Centre de rééducation physique, d'orthoptie et d'orthopédie ;
- * Centres d'appareillage,
- * Centres d'addictologie,
- * Centres médico-universitaires ;
- * Centres de soins palliatifs ;

❖ Espaces santé des jeunes :

« C'est un ensemble de services, cliniques et d'écoute accessibles et adaptés aux besoins spécifiques des jeunes, en matière de santé y compris la santé reproductive dont l'objectif étant d'adapter la réponse aux besoins spécifiques des jeunes et des adolescents en matière de santé... »

Créés dans le cadre d'une stratégie intégrée et multisectorielle, avec la participation effective des jeunes.

● Mission

Contribuer à la promotion de la santé des jeunes de **10 à 25** ans en leur offre et des services accessibles et adaptés en matière d'écoute, d'accompagnement psychosocial, de prise en charge et d'orientation médicale et psychologique y compris dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et de la lutte contre les addictions

- **Prestations**

- * Accueil, information et orientation.
- * Consultation médicale (suivi, référence).
- * Écoute et accompagnement psychologique.
- * Activités préventives et IEC (séances IEC thématiques, animation de groupe, Implication des parents et des ONG...).
- * Gestion du système d'information et documentation.
- * Coordination avec les partenaires.

Critère d'implantation :

- * Un ESJ est assimilé à un centre de santé urbain de deuxième niveau
- * Un ESJ pour 50 000 habitants
- * 01 ESJ/Province pour les provinces qui comptent moins de 50 000 habitants

❖ **Centre de rééducation physique, d'orthoptie et d'orthopédie :**

Selon l'OMS, la réhabilitation des personnes handicapées est « un dispositif leur permettant d'atteindre et de garder leurs niveaux fonctionnels physique, sensoriel, intellectuel, psychologique et social » ; ce dispositif comprend les outils nécessaires à leur autonomie.

La réhabilitation médicale et médicosociale a pour finalité de permettre aux personnes présentant des déficiences, incapacités ou handicap, leur réinsertion socioprofessionnelle.

❖ **Centres médico-universitaires :**

Le Centre médico- universitaire est une structure qui regroupe des professionnels médicaux et sociaux qui sont à l'écoute et proposent à titre gratuit : un accueil adapté, des consultations, des conseils et une orientation médicale et sociale pour les étudiants et le personnel administratif et technique de l'établissement universitaire.

- **Objectifs des CMU :**

Protéger et promouvoir la santé des étudiants afin qu'ils puissent suivre leurs études dans les meilleures conditions physiques, psychiques et sociales à travers des prestations préventives, curatives et promotionnelles.

- **Prestations**

- * Visite médicale systématique ;
- * Visite médicale à la demande ;
- * Soins infirmiers ;
- * Contrôle d'hygiène et de salubrité ;
- * Éducation sanitaire ;
- * Écoute et conseil ;
- * Assistance sociale.
- **Les normes d'implantation des CMU** par ville universitaire sont fonction des effectifs des étudiants, du nombre d'établissements universitaires et de l'existence ou pas de cité universitaire, Ces normes sont comme suites :
 - * 01 CMU par cité universitaire ;
 - * 01 CMU pour 8000 à 10 000 étudiants.

La couverture sanitaire en milieu universitaire est régit par la convention de partenariat conclue entre le Ministère Santé et le Ministère de l'Enseignement Supérieur e définie le rôle et les attributions de chaque partie à savoir :

- ❖ **Centres d'addictologie**

Ces structures s'adressent généralement aux personnes préoccupées par leurs consommations à risques, abusives et/ou problématiques de substances psychoactives, licites ou non, y compris tabac et médicaments détournés de leur usage habituel

Le centre d'addictologie s'intègre dans le cadre de la Stratégie de Lutte contre les Addictions dont l'objectif est de contribuer à atteindre un niveau élevé de protection en termes de santé publique, de sécurité publique et de cohésion sociale

- **Statut :** Partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Ministère de la Santé, et le Ministère de l'Intérieur.
- **Objectifs :** les centres d'addictologie s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de l'accessibilité aux structures de prise en charge des Usagers de Drogues (UD)

- **Critères d'implantation :**

- * Taux de prévalence de l'usage et des dépendances élevés
- * Sur la base « d'évaluations rapides » de situations
- * Tendances à l'augmentation de l'usage de drogues

Domaines d'activités :

- * La réduction de la demande basée essentiellement l'information, la sensibilisation et l'éducation
- * La prise en charge des usagers de drogues consultations ambulatoires en matière d'addictions, un suivi thérapeutique des patients et orientation vers les structures hospitalières et de sevrage
- * La réduction des risques de contamination de VIH et hépatites liée à la consommation des drogues injectables via l'unité "**bas seuil d'exigence**" et l'unité mobile
- * Appui psychosocial et accompagnement communautaire des UD

❖ **Centres de soins palliatifs :**

Des centres qui fournissent des soins actifs qui s'inscrivent dans une approche globale des personnes atteintes d'une maladie grave évolutive ou terminale (tout en tenant compte des douleurs physiques et également de leurs souffrances psychologiques, sociales, spirituelles, ...) et dont le but est d'offrir la meilleure qualité de vie possible pour eux et leurs familles.

VI. La couverture sanitaire :

1. Le découpage sanitaire :

L'offre de soins doit être répartie sur l'ensemble du territoire national de manière équilibrée et équitable, sur la base de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins.

A cet effet le territoire national est découpé en territoire de santé qui constitue des bassins de desserte de la population desservie par un ou plusieurs établissements ou installation de santé.

La délimitation de ces territoires qui se base sur le découpage administratif du royaume, peut être complétée le cas échéant par un découpage spécifique fixé par le ministre de la santé en vue d'arrêter les territoires les plus pertinents pour l'action sanitaire.

a. Les territoires de santé sont :

- * Les circonscriptions sanitaires ;
- * Les préfectures et provinces sanitaires ;
- * Les régions sanitaires ;
- * Les territoires de santé interrégionaux ;

❖ La circonscription sanitaire :

- * La circonscription sanitaire représente le **territoire de base** dans le **découpage sanitaire** pour la planification de l'offre de soins et la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des plans d'actions sanitaires dont l'ensemble des prestations de soins de santé primaires relatives à la prévention, à la promotion de la santé et aux modes de vie sains, ainsi qu'aux soins liés à l'accouchement aux urgences de proximité et à la médecine générale doit être disponible.
- * La circonscription sanitaire peut être **rurale** ou **urbaine**
- * La circonscription sanitaire **rurale** correspond au territoire d'un **caïdat**
- * La circonscription sanitaire **urbaine** correspond au territoire d'un **arrondissement** dans les communes soumises au régime d'arrondissements ou au territoire de l'ensemble de la commune, lorsque celle-ci n'est pas découpée en arrondissements
- * Chaque **circonscription sanitaire** est **découpée** en **deux** ou **plusieurs secteurs** sanitaires.
- * Le **secteur** sanitaire correspond à l'**aire** de desserte d'un **centre de santé**

❖ Les préfectures et provinces sanitaires :

- * Les préfectures et provinces correspondent respectivement aux ressorts territoriaux des préfectures et provinces administratives du royaume.
- * Chaque préfecture est découpée en deux ou plusieurs circonscriptions sanitaires.
- * L'offre de soins au niveau d'une **préfecture** ou **province** sanitaire correspond, en plus des prestations de soins de santé primaires, des prestations de réhabilitation et des prestations hospitalières de **premier niveau**
- * La préfecture ou la province sanitaire constitue le champ d'intervention d'une délégation préfectorale ou provinciale relevant du ministère de la santé.

❖ Les régions sanitaires :

- * Les régions sanitaires correspondent au ressort territorial des régions administratives du royaume.
- * Chaque région sanitaire est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires.
- * L'offre de soins au niveau d'une région sanitaire comporte, en plus des prestations de soins du niveau préfectoral provincial, les prestations hospitalières du **deuxième niveau**
- * La région sanitaire constitue le champ d'intervention de la direction régionale de la santé relevant du ministère de la santé.

❖ Le territoire sanitaire inter- régional

Le territoire de santé inter-régional correspond au bassin de desserte d'une infrastructure d'un équipement d'une installation de santé ou d'une installation de haute technologie rendant des prestations à **caractère interrégional** notamment les prestations hospitalières du **troisième niveau** et les prestations fournies par les pôles d'excellence ou les centres de référence interrégional.

2. La couverture sanitaire :

A. Définition :

- * La couverture sanitaire est l'offre de prestations ou de services de santé à une population par le développement d'un dispositif ou d'unités opérationnelles dont la finalité est de prendre en charge les besoins de la population en matière de soins, de prévention et de réhabilitation de cette population.
- * La couverture sanitaire constitue d'abord une réponse organisée à des besoins de santé par des services de santé en vue d'assurer la prise en charge d'épisodes de risque ou d'épisodes de maladie d'une population déterminée.

B. Modes et stratégies de couverture sanitaire :

📁 La stratégie de couverture sanitaire permettant la dispensation des prestations de santé ou services de santé à la population est organisée selon trois modes :

- **Mode fixe,**
- **Mode mobile,**
 - * Visites à domicile (**VD**) ;
 - * Unités médicales mobiles (**UMM**) ; (Equipe mobile).
 - * Caravanes médicales spécialisées (**CMS**) ;
 - * Hôpitaux mobiles (**HM**) ;
- **Mode participatif (participation communautaire),**

📁 Les modes de couverture sanitaire sont définis en fonction de l'éloignement des localités de l'établissement de soins de santé primaire (Répartition kilométrique au tout de l'ESSP) :

Répartition kilométrique de la population	Mode couverture
< 3 km	Fixe
3 à 6 Km	Visite à domicile (VAD) ou relance
6 à 10 Km	Points de contact ou équipe mobile
> 10 Km	Equipe Mobile

a. Milieu rural :

❖ Mode fixe :

C'est l'implantation d'une formation de soins de santé de base d'une catégorie déterminée (DR, CSR1, CSR2) dans un lieu accessible pour la population, dans une aire géographique donnée.

Dans ce mode de couverture c'est la population des **localités situées dans un rayon de 6 km** qui se rend au niveau des formations sanitaires pour bénéficier des prestations sanitaires.

Les éléments à considérer pour la définition des fonctions et des structures de la formation de soins de santé primaires sont :

- La réponse de tous les niveaux aux besoins sanitaires essentiels de la population.
- L'organisation des moyens selon la complexité technologique de chaque niveau.
- L'appui technique nécessaire de chaque niveau pour ceux qui lui sont inférieurs.

❖ **Mode mobile :**

Il est développé à partir d'un ESSP et s'adresse à la population située en dehors de son aire d'influence et ayant des difficultés pour utiliser les services qu'il offre (**localités situées à plus de 6 km**). Il constitue le prolongement des services de la formation qui vont concerner la population de son territoire.

Ce mode dont la finalité est de soutenir, de renforcer le mode fixe pour étendre la couverture sanitaire et permettre la fourniture de prestations sanitaires à domicile ou à proximité.

C'est le personnel de santé qui se déplace pour se rendre chez la population située dans un **rayon de plus de 6km**, selon trois modalités :

i. La visite à domicile :

Cette modalité de couverture sanitaire constitue un élément essentiel de la stratégie mobile qui se traduit par la réalisation de visites aux foyers des bénéficiaires de cette action par des professionnels de santé dans le cadre de circuit de porte à porte, de relances et enquête épidémiologique.

Les visites à domicile constituent un modèle de prestation des services de santé qui peut être utilisé pour offrir plusieurs types de prestations aux différents bénéficiaires ciblés dans leurs domiciles. Les programmes de visites à domicile peuvent varier considérablement en matière d'objectifs, de bénéficiaires, de professionnel de santé, d'activités et d'horaires.

ii. L'équipe mobile : (Unités mobiles médicalisées)

Ce mode de couverture sanitaire basé sur la constitution d'une équipe mobile avec un moyen de mobilité (véhicule) dont la fonction de base est d'assurer les prestations sanitaires essentielles aux populations non touchées par une modalité précédente.

- * Elle vise l'extension de la couverture sanitaire aux populations enclavées (accès difficile).

- * Cette modalité se caractérise par la composition d'une équipe multidisciplinaire selon les besoins (médecin, technicien d'hygiène, sage-femme, infirmier polyvalent, ...)
- * Est souvent réalisée sous forme de planning de sorties (selon un rythme d'un passage chaque trois mois) avec objectifs bien déterminés.
- * Les localités situées à moins de 6 km en cas d'obstacles géographiques ou de situation épidémiologique particulière.
- * Le paquet d'activité doit être diversifié et intégré (Activités préventives, curatives et promotionnelles) Il doit :
 - Répondre aux besoins et aux attentes de la population cible.
 - S'inscrire dans les objectifs des programmes sanitaires.
 - Prendre en considération le profil épidémiologique des localités cibles.

iii. La caravane médicale :

- * Est une intervention de santé, limitée dans l'espace et dans le temps (1 à 3 jours), elle mobilise des ressources (humaines, matérielles, et financières) pour délivrer des prestations sanitaires (promotionnelles, préventives et curatives) au profit d'une population nécessiteuse ayant des difficultés d'accès aux prestations de soins spécialisées.
- * Elle complète les interventions de l'équipe mobile.
- * Elle peut-être :
 - Multidisciplinaire : associant plusieurs spécialités
 - Spécialisée : focalisée sur un problème de santé ou une spécialité.
- * Elle constitue un espace favorisant davantage implication des médecins spécialistes dans les actions de santé publique.
- * Elles peuvent être organisées soit par :
 - Les régions avec des partenaires.
 - Le Ministère de la santé selon un programme national pré- établi.

iv. L'hôpital mobile :

Cette structure médicale mobile est un hôpital multidisciplinaire offrant en plus des consultations spécialisées, la possibilité d'effectuer des examens paracliniques, des interventions chirurgicales et l'hospitalisation des malades et ce dans l'objectif principal de desservir la population des zones enclavées ou en cas de situation d'urgences. (Exemple : vagues de froide).

L'hôpital mobile civil dispose de la majorité des spécialités médicales et chirurgicales et de tous les équipements et des services d'appui nécessaires,

Cet hôpital mobile vise l'atteinte de deux objectifs :

- Assurer une couverture de proximité dans le cadre du plan de santé rurale.
- Intervention lors des situations d'exception telle les vagues de froid et autres.

Le paquet d'actions minimum :

- * L'identification et la connaissance de la population à charge.
- * La fourniture des soins curatifs pour des maladies courantes et fréquentes.
- * La surveillance épidémiologique.
- * La vaccination contre les principales maladies infectieuses du jeune enfant.
- * La lutte contre les maladies diarrhéiques.
- * La lutte contre les maladies de carence de la mère et de l'enfant.
- * La surveillance pré et post-natale.
- * La planification familiale.
- * L'amélioration des conditions de l'accouchement.
- * La lutte contre les principales maladies transmissibles (maladies à transport hydrique, paludisme, tuberculose, bilharziose, etc.)
- * La lutte contre les maladies non transmissibles (maladies mentales, diabète...).
- * L'hygiène scolaire et universitaire.
- * La référence des maladies au niveau approprié.
- * L'information, la motivation et l'éducation de la population

❖ La participation communautaire :

➤ Définition :

C'est un processus dans lequel les individus et les familles, d'une part prennent en charge leur propre santé et leur propre bien être, comme ceux de la communauté, d'autre part développent leur capacité à concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté.

« Déclaration d'ALMA ATA 1978 »

Les principales actions communautaires développées au Maroc sont :

i. Dar Al Oumouma :

Espace d'accueil des parturientes du milieu rural durant les jours qui précèdent l'accouchement et après l'accouchement. Elle offre l'hébergement, l'alimentation et autres services d'hôtellerie, ainsi que les prestations d'éducation sanitaire : C'est une structure communautaire gérée par la population, organisée en association.

ii. SAMU Obstétrical Rural

Le Système d'Assistance Médicale Urgente Obstétricale (SAMU)

Est un dispositif d'organisation et de régulation des urgences obstétricales et néonatales. Il vise à faciliter l'accès des femmes du milieu rural aux structures de soins pour la prise en charge d'un accouchement et/ou de ses complications en milieu surveillé.

Composantes et organisation du SAMU-OR

Le dispositif du SAMU-OR est articulé autour de 3 principales composantes :

- * **Structures de soins** : maisons s'accouchement, maternités hospitalières et services de néonatalogie ;
- * **Moyens de mobilité** : ambulances avec un équipement de base indispensable, une dotation de fonctionnement suffisante et chauffeur pour assurer un transfert dans de bonnes conditions ;
- * **Moyens de communication téléphonique** : constitués de GSM mis à la disposition du personnel de santé et personne relai communautaire impliqué dans le dispositif.

Ces composantes sont organisées en réseau dont la régulation est assurée par la sage-femme de la maison d'accouchement la plus proche.

iii. Éducation Parentale :

Approche visant le changement de comportement des parents pour promouvoir la santé de l'enfant et de la mère et assurer un développement physique et psychologique harmonieux, à travers un agent relais communautaire ayant subi une formation adéquate.

iv. Classes des mères : La Classe des Mères vise le changement des comportements et responsabilise les parents de leur propre santé ainsi que de celle de leurs enfants et contribue à renforcer le continuum des soins. Or, il est démontré qu'en renforçant le continuum des soins, on augmente les chances d'améliorer la santé et le bien être des mères et des enfants.

v. Initiative à base communautaire de l'Expérience de la région Taza Al Hoceima Taounate

Approche qui s'appuie sur les volontaires communautaires (personnes relais communautaires) dans le cadre des programmes de santé

- * Délégation à de volontaires communautaires (personnes relais) après leur formation et encadrement, au niveau de localités enclavées et en partenariat avec des associations, d'activités de santé tel que :
- * Santé de la mère : Planification familiale, surveillance de la grossesse et accouchement ; références, et éducation pour la santé.

b. Milieu urbain :

- Le mode fixe est représenté par les centres de santé urbains (CSU1 ou CSU2) qui assurent les soins de santé de primaires sur place.
- Ce mode est appuyé par des visites à domiciles par les infirmières de la formation sanitaire (CSU1 ou CSU2) pour certaines tâches en dehors du centre. (Relances de vaccinations, de consultations pré et postnatale...)

VII. Le circuit du malade & filière de soins :

a. Définition de concepts :

*** Parcours de soins coordonné :**

- C'est une organisation des prises en charge individuelles coordonnée entre plusieurs prestataires de soins ;
- Elle permet :
 - D'assurer une prise en charge globale du patient
 - Orienter le patient vers le bon interlocuteur pour gagner en efficacité et en qualité des soins (Eviter la multiplication des examens et des traitements).

* **Filière de soins :** La filière de soins : une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins, représenté par le médecin généraliste ou médecin traitant, et des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et protocoles thérapeutiques quand ils existent. (Ex : SONU).

* **Un réseau de soins :** est une offre multidisciplinaire coordonnée et organisée d'action collective des soins apportée par des professionnels en réponse à un besoin de santé des individus et/ou de la population, à un moment donné sur un territoire donné".

* **Réseau coordonné des soins :** une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise

En charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Il vise le renforcement de la coordination d'une prise en charge médicale multidisciplinaire. (RESSP, RH)

b. Filière globale des soins :

- La notion de filière est entendue comme le cheminement du malade entre les structures de soins ;
- Ce cheminement traverse les réseaux de soins et bénéficie des programmes de santé
- Les patients sont orientés à partir du dispensaire rural ou de l'équipe mobile vers le centre de santé rural le plus proche et le plus adapté, qui à son tour peut le référer à un niveau supérieur (hôpital de proximité, provincial ou région

L'accès aux services de soins, en cas de référence, obéit à certaines conditions à savoir :

*** Accès au spécialiste**

Cet accès est conditionné par :

- Un passage obligatoire par le médecin généraliste ;
- Une orientation hiérarchisée vers les autres spécialistes.

*** Accès à l'hospitalisation**

L'admission en hospitalisation est assurée par trois

🏠 La Consultation Spécialisée :

- * Centre de consultation spécialisée externe « CCE »,
- * Centre de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires « CDTMR »,
- * Centre de Référence en Santé de la Reproduction « CRSR »

🏠 Les Services des Urgences ;

🏠 L'Hôpital de jour.

Par ailleurs, cette hospitalisation est hiérarchisée en fonction des niveaux allant de l'Hôpital de proximité, l'Hôpital Provincial ou Préfectoral, l'Hôpital Régional jusqu'au CHU.

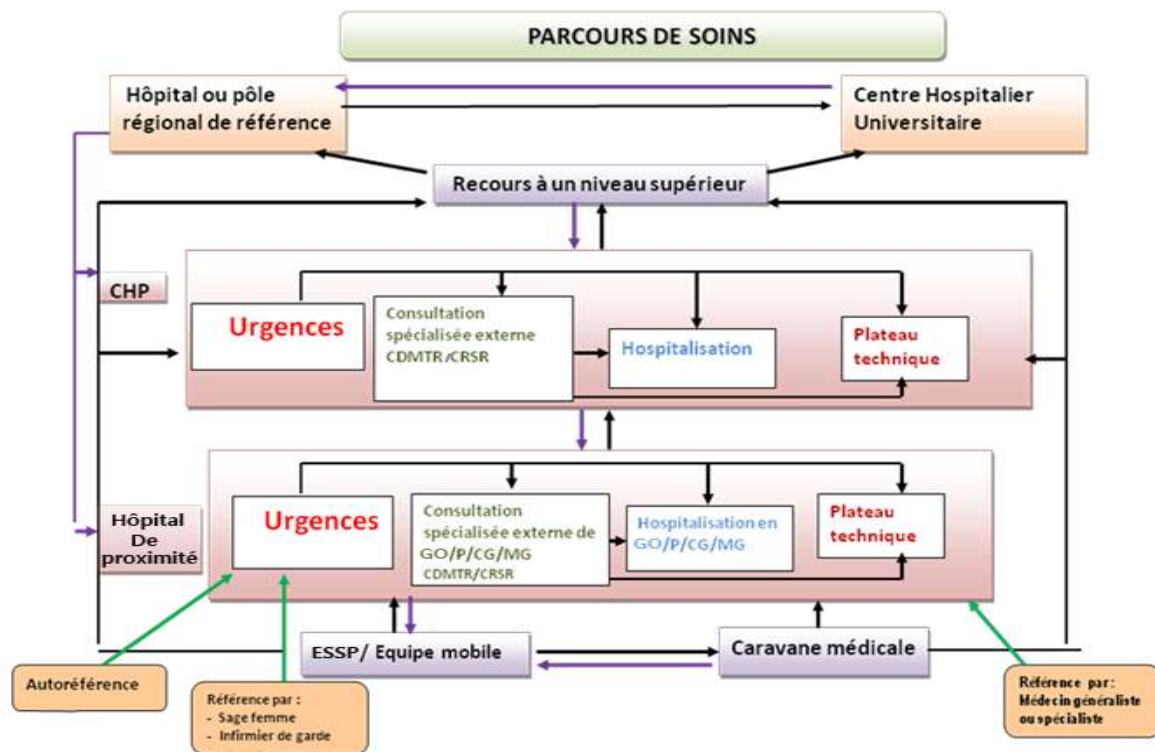
➤ Accès aux urgences

L'accès aux urgences peut être :

- Une auto référence dont la prise en charge sera fonction des résultats de l'évaluation de l'urgence (service de triage) ;
- Une référence par un médecin généraliste ou spécialiste ;
- Une référence par une sage-femme ou un infirmier de garde.

➤ Accès au plateau technique

L'accès au plateau technique ne doit se faire que sur une ordonnance médicale délivrée par un médecin généraliste ou spécialiste.



C. Système de référence et contre référence :

➤ Référence :

C'est l'orientation et/ou le transfert du patient à un niveau supérieur de soins.

La référence peut être justifiée par : Le manque de compétences appropriées ; L'insuffisance du plateau technique.

➤ Contre référence :

C'est la réorientation du patient et / ou le retour de l'information le concernant vers le niveau référant.

- L'objectif est d'assurer à la population référée une prise en charge de qualité à travers des services de soins intégrés et continus.
- Les Supports de référence contre référence utilisés sont :

- 📄 Fiche de référence / contre référence (carnet à souches)
- 📄 Registre de références ;

d. Filières de soins spécifiques :

i. Prise en charge des accouchements et des complications obstétricales

Les parturientes sont soit auto référée de leur domicile ou régulées à travers un SAMU obstétrical rural à un SOUB qui est le CSCA ou le CSUA qui assure les soins obstétricaux de base, puis en cas de besoin (transfusion sanguine, césarienne, réanimation) elles sont référées à un SOUC qui est le centre hospitalier adapté qui assure les soins obstétricaux.

➤ Le régime d'autorisation des installations de haute technologie et des équipements biomédicaux lourds :

L'implantation de tout équipement biomédical lourd et l'implantation de toute installation de haute technologie par des établissements de santé publics ou privés, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de la santé.

➤ La commission nationale et les commissions régionales de l'offre de soins

- * La commission nationale de l'offre de soins a pour mission, de donner son avis sur le projet de la carte sanitaire et sur tout projet de révision de celle-ci.
- * Elle est présidée par le **Ministre de la Santé** ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le secrétaire général du ministère de la santé.
- * Est tenue de se prononcer par avis sur les projets qui lui sont soumis dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de sa saisine.
- * Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- * Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la DHSA relevant du ministère de la santé.

➤ Les membres de la commission nationale de l'offre de soins

- * Deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'**Intérieur**, dont le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- * Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'**économie et des finances** ;
- * Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'**aménagement du territoire** ;
- * Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'**enseignement supérieur** ;

- * Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de **l'équipement et de la logistique** ;
- * Un représentant du **haut-commissariat au plan** ;
- * L'inspecteur du service de santé des **Forces Armées Royales** ou son représentant ;
- * Le président du conseil national de **l'ordre national des médecins** ou son représentant ;
- * Le président du conseil national de **l'ordre des pharmaciens** ou son représentant ;
- * Le président du Conseil National de **l'ordre des médecins dentistes** ou son représentant ;
- * Les directeurs des **centres hospitaliers** régis par la loi 37-80 ;
- * Les **directeurs de l'administration centrale** du Ministère de la santé ;

➤ **La commission régionale de l'offre de soins**

- * Chaque commission régionale de l'offre de soins a pour mission de donner son avis sur le projet de SROS relatif à l'espace territorial de la région concernée et sur tout projet de révision de celui-ci.
- * Chaque commission régionale de l'offre de soins est présidée par **le wali** de la région concernée ou son représentant.
- * Le secrétariat de la commission régionale est assuré par la **direction régionale de la santé**.
- * Chaque commission régionale est tenue de donner son avis sur le projet qui lui est soumis dans un délai maximum de 60 jours à compter de sa saisine.

➤ **Les membres de la commission régionale de l'offre de soins**

- * Les **gouverneurs** des préfectures et provinces de la région ou leurs représentants ;
- * Le président du **conseil de la région** ou l'un des vice-présidents de ce conseil ;
- * Le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de **l'aménagement du territoire** au niveau de la région ;
- * Le Président du conseil régional de **l'ordre national des médecins** ou son représentant ;
- * Le Président du conseil Régional de **l'ordre des Pharmaciens** d'officines ou son représentant ;
- * Le Président du conseil régional de **l'ordre des médecins dentistes** ou son représentant ;

- * Le directeur du **Centre Hospitalier interrégional**, dont le siège se trouve au niveau de la région ;
- * Trois représentants des **directions centrales** relevant du Ministère de la santé désignée par le Ministre de la santé ;
- * Le **directeur régional de la santé** ;
- * Les **délégués du ministère de la santé** aux préfectures et provinces de la région.

VIII. Les programmes de santé

Définition d'un programme de santé :

Un programme de santé est constitué par un ensemble de ressources réunies et mises en œuvre pour fournir à une population **définie des** services organisés de façon cohérente dans le temps et dans l'espace en vue d'atteindre des objectifs déterminés en rapport avec un **problème de santé précis**.

L'organisation en programmes de santé au Maroc :

- * Un programme est un ensemble de services et d'activités intégrés, destinés à une population particulière (cible), visant des résultats spécifiques.
- * L'organisation a permis de relever le défi des maladies cibles de la vaccination et des maladies endémo-épidémiques ;
- * Extension progressive vers les maladies non transmissibles et la santé de populations vulnérables

Programme de santé : 3 dimensions

- * Problème de santé
- * Population cible
- * Milieu particulier

Composantes d'un programme de santé :

- * Contexte et situation problématique
- * Objectifs généraux et spécifiques
- * Population(s) cible(s)
- * Stratégie(s) : axes d'interventions, actions
- * Activités et ressources mobilisées
- * Indicateurs de suivi

Programmes développés par le Ministère de la Santé

- * Programmes de la santé de la mère et de l'enfant
- * Programmes de santé des populations à besoins spécifiques
- * Programmes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles
- * Programmes de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles
- * Programmes de santé environnement

a. Programmes de la santé de la mère et d'enfant

Mère :

- * Programme national de surveillance de la grossesse et de l'accouchement
- * Maternité sans risque
- * Programme national de planification familiale
- * Allaitement maternel

Enfant :

- * Programme national d'immunisation
- * Programme national de lutte contre les maladies de carences.
- * Programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques
- * Programme national de lutte contre les IRA
- * Prise en charge intégrée de la santé de l'enfant

b. Programmes de santé des populations à besoins spécifiques :

- * Programme national de Santé scolaire et universitaire
- * Santé des jeunes
- * Handicap et personnes âgées (programmes de réhabilitation, gériatrie)
- * Protection des femmes et enfants victimes de violence

c. Programmes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles :

- * PNLAT : Programme national de lutte contre la tuberculose
- * Lutte contre les IST/SIDA
- * - Maladies parasitaires (paludisme, leishmaniose, bilharziose, hydatidose, schistosomiase,)
- * Maladies cibles de la vaccination (poliomyélite, diphtérie, tétanos,)
- * Maladies épidémiques (méningites, hépatites virales, rougeole, fièvre typhoïde, TIAC,)
- * Programme national de lutte contre la cécité (trachome)
- * Lutte contre la lèpre et maladies dermatologiques (lèpre)
- * Zoonoses (rage, le charbon, la leptospirose et la brucellose)
- * Programme de Surveillance épidémiologique

d. Programmes de prévention et de lutte contre les maladies non Transmissibles :

- * Prévention et lutte contre le diabète
- * Prévention des maladies cardio-vasculaires
- * Lutte contre le cancer
- * Lutte contre le tabagisme
- * Lutte contre l'insuffisance rénale chronique.
- * Santé mentale
- * Lutte contre la toxicomanie
- * Santé des travailleurs
- * Santé bucco-dentaire
- * Santé respiratoire (asthme, BPCO, ...)
- * Maladies rares : hémophilie, thalassémie, ...

e. Programmes de santé environnement :

- * Contrôle de l'eau de boisson
- * Assainissement de base
- * Lutte contre les vecteurs
- * Hygiène alimentaire

f. Plans et stratégies nationales :

- * Plan national pour l'organisation et le développement des soins médicaux d'urgence
- * Plan d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale
- * Plan d'accélération de la réduction de l'incidence de la tuberculose
- * Stratégie nationale de prise en charge intégrée des femmes et des enfants victimes de violences.
- * Stratégie nationale de toxicovigilance
- * Stratégie nationale de pharmacovigilance
- * Plan national de santé rurale
- * Plan stratégique national de VIH-SIDA

IX. Ressources humaines du Ministère de la santé

1- Les différentes catégories

a. Personnel médical

- Les médecins généralistes
- Les médecins spécialistes en :

Anatomopathologie - Anesthésie - Biologie - Cardiologie - Chirurgie générale - Chirurgie infantile - Dermatologie - Endocrinologie - Gastrologie - Gynécologie - Hématologie - Médecine interne - Médecine de travail - Neurologie - Neurochirurgie - Néphrologie - Neuropsychiatrie - Ophtalmologie - ORL - Pédiatrie - Pneumo-phtisiologie - Radiologie - Rhumatologie - Santé publique - Chirurgie thoracique - Urologie - Orthopédie - Stomatologie....

a. Personnel paramédical

(En attendant l'application totale du système LMD nous continuons avec les nominations ci-dessous) :

- Assistant médical - IDE grade principal - IDE 1er grade - IDE 2ème grade - ASB auxiliaire principal - ASB auxiliaire 1ème grade - ASB auxiliaire 2ème grade.....

b. Personnel administratif

- Administrateur divisionnaire principal - Administrateur divisionnaire – Administrateur économe.
- Econome - Rédacteur - Rédacteur principal - Secrétaire - Secrétaire principal

- Technicien 1er grade -Technicien 2ème grade - Adjoint technique
- Agent de service - Agent de service principal - Agent d'exécution - Agent d'exécution principal
- Agent public 4ème catégorie - Agent public 3ème catégorie - Agent public 2ème catégorie
- Agent public 1ème catégorie - Agent public hors catégorie - Agent public hors catégorie principal

C. Autres catégories

- * Ingénieurs
- * Psychologue
- * Professeurs d'enseignement supérieur.

La formation du personnel

Le personnel médical

La formation des médecins généralistes

Pour une meilleure adéquation formation/emploi et pour faire face aux exigences de l'exercice de la profession médicale et aussi pour mieux répondre aux priorités nationales en matière de santé, la réforme des études médicales s'impose d'elle-même. Ainsi en 1982 qu'elle s'est opérée et son application a commencé depuis 1983. Le nouveau cursus trace les objectifs généraux ci-après :

- * Introduire une verticalité entre les sciences de base et les sciences cliniques, et une horizontalité entre l'enseignement théorique et les stages pratiques.
- * Baser le contenu de l'enseignement sur les données terminologiques, sociales, épidémiologiques et sur les grands problèmes de santé.
- * Introduire des modules de formation sur les données socio psychologiques, démographiques, épidémiologiques, sur l'infrastructure sanitaire et les programmes d'activités sanitaires.
- * Programmer des stages cliniques dès la première année des études pour initier les étudiants en médecine aux problèmes de santé commentaire, et la prise de contact avec les structures sanitaires, le malade et la maladie.
- * Inclure un stage de soins infirmiers et de sémiologie dès la deuxième année des études.
- * Valoriser les travaux pratiques, les travaux dirigés et les stages.

- * Appliquer un nouveau système d'évaluation.

De même, pour permettre l'amélioration de l'encadrement des médecins et de créer des pôles d'excellence en matière de soins et de recherche, en plus des CHU de Rabat et Casablanca la formation médicale a été étendue au niveau régional par la création de CHU à Fès, à Marrakech et à Oujda.

La formation des médecins spécialistes

Les besoins en médecins spécialistes restent importants au niveau national, avec une inégalité de répartition entre les grandes villes et les autres provinces du Royaume. Ceci laisse entendre que des efforts doivent être fournis dans le domaine de la formation des médecins spécialistes dans les années à venir, notamment dans certaines spécialités de base : chirurgie générale, l'obstétrique, la gynécologie, l'anesthésie, réanimation, la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique, la pneumo-ptisiologie, la psychiatrie, l'ophtalmologie et la biologie clinique.

La formation des pharmaciens

Cette formation a pour but de former des pharmaciens adaptés aux exigences de notre pays dans le domaine de la pharmacologie et capables de contribuer au bien-être des citoyens en matière de santé. La formation des pharmaciens a débuté 1986 à la Faculté de Rabat. Actuellement, quatre-vingt (80) pharmaciens sont formés chaque année, chiffres auxquels s'ajoutent les Lauréats formés à l'étranger.

La Formation en médecine dentaire

Les deux facultés de médecine dentaire de Rabat et Casa ont été créées en 1981 pour répondre aux besoins en médecins dentistes.

En conclusion, malgré les efforts de l'Etat enregistrés dans le domaine de la formation des médecins, des pharmaciens et des dentistes, et quelle que soit la pertinence des cursus actuellement en vigueur, la formation continue s'impose pour accompagner les changements qui se produisent rapidement dans les connaissances scientifiques et techniques.

Le personnel paramédical

Le service de formation de base est l'organe chargé de la formation initiale du personnel para médical. Avant d'aborder le volet formation, il convient de situer ce service au niveau de l'organigramme du ministère de la santé.

La division de la formation est rattachée à la direction des ressources humaines. Elle comprend deux services : le service de la formation de base qui orchestre les sept instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé et le service de la formation continue qui fera l'objet d'un chapitre ultérieur.

Depuis l'indépendance, notre pays est appelé à investir des efforts considérables dans la formation du personnel para médical pour répondre aux besoins de la population en prestations sanitaires.

Dans un premier temps et pour aller vite, cette formation est axée sur les aides sanitaires (profil institué par arrêté ministériel du 23. 9.1957 BO n°2353 du 29/11/1957.

Ensuite, la formation des infirmiers (ères) diplômés d'état n'a été effective qu'à 1960 et 1963 pour le profil cariste.

A la fin de l'année 1989, l'appareil de formation des ASB comportait 27 écoles d'ASB et 22 écoles d'ASDE (toutes options confondues).

A partir de 1986, 26 écoles d'ASB ont cessé de fonctionner. Celles des infirmiers diplômés d'état ont continué à former de petits effectifs. La formation du profil cariste est restée en veilleuse jusqu'à son sursis en 1993.

Tombé dans l'obsolescence, le système de formation para médical est devenu sujet à une réforme pour apporter de nouvelles structures de formation mieux adaptées à la situation actuelle et améliorer la formation de base des cadres infirmiers en élevant le niveau d'accès en premier cycle de formation et en portant la durée des études à trois ans au lieu de deux.

C'est dans cette vision que les instituts de formation aux carrières de santé ont été créés par Décret n°2.93.602 du 29 octobre 1993.

Pour accompagner l'évolution enregistrée dans le domaine de la pratique infirmière, le ministère de la Santé s'est adhérent à cette dynamique par l'alignement des ISPITS à la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur.

Instituts supérieurs des professions infirmières et des techniques de santé :

Missions :

Vu le décret N° 2-13-658 du 23 Di Alkiaada 1434 (30 septembre 2013) portant création des ISPITS.

Les instituts Supérieurs des Professions Infirmières et des Techniques de Santé sont des établissements de l'enseignement supérieur ne relevant pas des universités et qui sont sous la tutelle du Ministère de la Santé.

Les ISPITS assurent la préparation et la délivrance des Diplômes nationaux organisés en trois cycles d'études (Cycle de la Licence professionnelle, Cycle de Master et Cycle du Doctorat) dans les domaines des professions infirmières et des techniques de santé.

Les ISPITS ont pour missions principales :

- * La formation initiale dans le domaine des professions infirmières et des techniques de santé (pour le système national de santé avec ses secteurs : public, semi public et privé) tout en établissant une interaction dynamique entre la pratique professionnelle et les fondements de la discipline.
- * La formation continue et la recherche scientifique et technologique favorisant l'avancement des savoirs infirmiers, l'amélioration de la santé des personnes, le renouvellement des pratiques infirmières et techniques sanitaires et l'organisation des services et des soins infirmiers.
- * La réalisation d'expertises liées aux domaines des professions infirmières et des techniques de santé.

Accès aux diplômes

Licence :

- * En S1 : Bac + pré requis spécifiques à la filière
- * En S3 : Etudiants ayant validé S1 et S2 d'une filière accréditée + pré requis spécifiques à S3.
- * En S5 : Etudiants ayant validé S1 à S4 d'une filière accréditée + pré requis spécifiques à S5.

Master : Licence ou diplôme équivalent.

Doctorat : Master ou diplôme équivalent.

Carte d'implantation des 25 ISPITS

12 Instituts	13 Annexes
Rabat	Rabat, Kenitra
Casablanca	Casablanca, Settat
Oujda	Oujda, Nador
Fès	Fès, Meknès, Taza
Marrakech	Marrakech, Essaouira, Safi
Agadir	Agadir, Tiznit,
Tanger/Tétouan	Tanger , Tétouan, Al Hoceima
Rachidiya	errachidia, Ouarzazate, zagora
Laayoune	Laayoune
Dakhla	Dakhla
Bni melal	Béni mellal, khénifra
Goulmin	Guelmim

Les filières de formation

05 Filières	24 Options
Soins infirmiers	Infirmier polyvalent
	infirmier en santé mentale
	Infirmier en anesthésie réanimation
	Infirmier en soins d'urgences et soins intensifs
	Infirmier en santé de famille et santé communautaire
	Infirmier en néphro-dialyse
	Infirmier en gériatrie
	Infirmier de bloc opératoire
	Infirmier en néonatalogie et pédiatrie
Sage-femme	Sage-femme
Techniques de santé	Laboratoire
	Santé de l'environnement
	Radiologie
	Diététique/Nutrition
	Préparateur en pharmacie
	Maintenance biomédicale
	Statistiques sanitaires
Rééducation et réhabilitation	Orthoprothésie
	Kinésithérapie
	Orthophonie

	Orthoptie
	Psychomotricité
	Ergothérapie
Assistance Médico – sociale	Assistant social

La formation des techniciens de santé

Profil institué par arrêté du ministre de la santé n° 1067-94 du 30 mars 1994 modifié et complété par arrêté n° 28881-95 du 12 décembre 1995 portant création des instituts de formation de techniciens de santé (IFTS)

L'accès aux IFTS

- * Sélection des dossiers sur la base des notes obtenues à la 3° AS
- * Concours comportant une épreuve écrite d'une durée de 60 mn avec coefficient 1
- * Entretien avec une petite commission multidisciplinaire composée de 3 personnes ressources.
- * Les candidats ayant rempli avec succès les conditions précitées auront accès à une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans l'un des IFTS sus indiqués.
- *
- * Ecole Nationale de Santé Publique ENSP
- *
- * L'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), qui a pris son nom en vertu du décret n° 2-12-904 (du 27 Joumada I 1434 (8 avril 2013)), est l'héritière de 'Institut National de l'Administration Sanitaire (INAS) créé en 1989
- * La raison d'être de l'ENSP est de répondre aux besoins du système de santé marocain par la formation des cadres de haut niveau capables de relever les défis quotidiens auxquels ce système est confronté et également d'accompagner les réformes envisagées par le Ministère de la Santé
- * Les missions de l'Ecole Nationale de Santé Publique sont : la formation initiale (qui consiste en la dispensation des formations de base relatives aux filières de spécialisation en

santé publique et en management de la santé), la formation continue, la recherche scientifique et l'expertise. Si les deux premières missions visent le renforcement des compétences, les deux autres missions ciblent quant à elles, à apporter une aide précieuse à la prise de décision.

- * La formation initiale au niveau de l'Ecole Nationale de Santé Publique est organisée actuellement en quatre filières :
 - ✓ Management hospitalier (MH)
 - ✓ Gestion des Programmes de Santé (GPS)
 - ✓ Epidémiologie de Santé Publique (ESP)
 - ✓ Santé de Famille et Santé Communautaire (SFSC)
- * Il s'agit d'une formation modulaire à plein temps organisée sous forme de :
 - ✓ Cours théoriques
 - ✓ Stage d'intégration professionnelle
 - ✓ Mémoire de fin d'études